

ANTARA STIGMA DAN HARAPAN

PSIKOLOGI IBU POSTPARTUM DENGAN HIV/AIDS

Susi Lestari ● Arum Surya Utami ● Eftiyaningrum Dwi Wahyu Astutik
Endah Purwanti Handayani ● Hasnia

ANTARA STIGMA DAN HARAPAN: PSIKOLOGI IBU POSTPARTUM DENGAN HIV/AIDS

Penulis:

Bdn. Susi Lestari, S.ST., M.Kes

Arum Surya Utami, S.Tr.Keb., M.Keb

Eftiyaningrum Dwi Wahyu Astutik, M.Tr.Keb

Endah Purwanti Handayani, S.ST., M.Tr.Keb

Hasnia, S.Tr.Keb., M.Keb.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

**Antara Stigma dan Harapan:
Psikologi Ibu Postpartum dengan HIV/AIDS**

Penulis: Bdn. Susi Lestari, S.ST., M.Kes.
Arum Surya Utami, S.Tr.Keb., M.Keb.
Eftyaningrum Dwi Wahyu Astutik, M.Tr.Keb.
Endah Purwanti Handayani, S.ST., M.Tr.Keb.
Hasnia, S.Tr.Keb., M.Keb

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7097-49-1

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:
Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB

Antara stigma dan harapan : psikologi ibu postpartum dengan HIV /
penulis, Bdn. Susi Lestari, S.ST., M.Kes., Arum Surya Utami,
S.Tr.Keb., M.Keb., Eftyaningrum Dwi Wahyu Astutik, M.Tr.Keb.,
Endah Purwanti Handayani, S.ST., M.Tr.Keb., Hasnia, S.Tr.Keb.,
M.Keb.

EDISI
PUBLIKASI
DESKRIPSI FISIK
IDENTIFIKASI
SUBJEK
KLASIFIKASI
PERPUSNAS ID

Cetakan pertama, Februari 2025
Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025
vi, 90 halaman ; 30 cm
ISBN 978-634-7097-49-1
Persalinan -- HIV (Virus), Infeksi
618.76 [23]
<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1074973>

PRAKATA

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, buku ini hadir dengan judul **"Antara Stigma dan Harapan: Psikologis Ibu Postpartum dengan HIV/AIDS."** Buku ini disusun untuk mendalami aspek psikologis yang dialami oleh para ibu yang, di tengah perjuangan merawat anak pasca persalinan, juga harus menghadapi tantangan kesehatan serius.

Diagnosis HIV/AIDS pada ibu postpartum membawa dampak tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga pada stigma sosial yang dapat memengaruhi kondisi mental dan emosional mereka. Penulisan buku ini didorong oleh keprihatinan terhadap banyaknya ibu yang menjalani masa postpartum dengan beban ganda: peran baru sebagai seorang ibu sekaligus perjuangan hidup dengan HIV/AIDS. Di samping tantangan fisik, para ibu ini sering menghadapi diskriminasi dan prasangka dari masyarakat, yang memperberat kondisi psikologis mereka.

Buku ini diharapkan mampu membuka wawasan pembaca tentang perasaan, pikiran, dan perjuangan yang dialami oleh para ibu tersebut, sekaligus memberikan perspektif baru untuk mendukung mereka dengan lebih baik. Penulis berharap buku ini dapat membangkitkan empati dan pemahaman yang mendalam terhadap situasi para ibu ini. Lebih jauh, buku ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi stigma terhadap HIV/AIDS, khususnya pada ibu yang baru melahirkan, serta mendorong adanya dukungan yang lebih luas bagi mereka. Semoga buku ini menjadi inspirasi untuk melihat bahwa di balik tantangan besar, selalu ada harapan yang dapat dibangun bersama.

Januari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	ii
--------------	----

DAFTAR ISI.....	iv
-----------------	----

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
-------------------------------	----------

BAB 2 KONSEP HIV/AIDS.....	7
-----------------------------------	----------

A. Defenisi HIV/AIDS.....	7
---------------------------	---

B. Sejarah HIV/AIDS	8
---------------------------	---

C. Gejala HIV/AIDS.....	9
-------------------------	---

D. Penularan HIV/AIDS.....	14
----------------------------	----

E. Pencegahan HIV/AIDS	16
------------------------------	----

F. Pengobatan HIV/AIDS	18
------------------------------	----

BAB 3 STIGMA DALAM KONTEKS HIV/AIDS	23
--	-----------

A. Defenisi Stigma.....	23
-------------------------	----

B. Dampak Stigma pada Individu	30
--------------------------------------	----

C. Pengalaman Stigma yang Dialami Ibu Postpartum dengan HIV/AIDS.....	33
--	----

BAB 4 PSIKOLOGI IBU POSTPARTUM	41
---	-----------

A. Defensi Ibu Postpartum.....	41
--------------------------------	----

B. Perubahan Psikologi setelah Melahirkan.....	43
C. Tantangan Emosional yang Dihadapi Oleh Ibu dengan HIV / AIDS.....	46
D. Psikologis Ibu Postpartum dengan HIV/AIDS.....	49

BAB 5 HARAPAN DAN DUKUNGAN 51

A. Pentingnya Dukungan Sosial Bagi Ibu Postpartum.....	51
B. Sumber Dukungan dan Cara Mengatasi Stigma	52
C. Peran Komunitas Dan Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Ibu.....	56
D. Hasil Penelitian Terkait Dukungan kepada Ibu.....	61

BAB 6 PENUTUP 69

DAFTAR PUSTAKA 73

PROFIL PENULIS..... 79

BAB 1

PENDAHULUAN

Permasalahan global saat ini semakin kompleks, mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, politik, pendidikan, keamanan, lingkungan, hingga kesehatan. Salah satu isu kesehatan yang terus menjadi perhatian dunia adalah penyebaran virus HIV. Penyebaran yang semakin cepat menjadikan HIV sebagai masalah signifikan, terutama di negara-negara berkembang.

Kasus HIV dan AIDS telah menjadi isu penting sejak pertama kali dilaporkan pada tahun 1981, menarik perhatian tidak hanya di kalangan medis, tetapi juga para pembuat kebijakan, pemuka agama, dan masyarakat global. Hingga kini, perkembangan kasus HIV dan AIDS terus meningkat, terutama karena belum ditemukannya vaksin untuk mencegah penyakit ini (Utami, 2017).

Awalnya, kasus HIV dan AIDS ditemukan pada kelompok homoseksual, namun risiko penularannya kini mencakup semua individu tanpa terkecuali. HIV tidak hanya mengancam populasi dengan perilaku berisiko tinggi, tetapi juga telah menginfeksi ibu rumah tangga, anak-anak, bahkan bayi yang tertular dari ibu mereka selama kehamilan. Meski demikian, penularan HIV masih paling sering terjadi melalui hubungan seksual, terutama yang melibatkan pekerja seks, baik sebagai sumber maupun penerima infeksi (Purwaningsih, 2018).

Menurut Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), faktor-faktor risiko utama penularan HIV meliputi hubungan seksual tanpa pengaman, penggunaan jarum suntik tidak steril

secara bergantian, transfusi darah yang terkontaminasi, serta penularan dari ibu yang terinfeksi HIV kepada anak yang dikandungnya (Cory'ah, 2018).

Di Indonesia, kasus HIV dan AIDS pertama kali terdeteksi pada tahun 1987 di Bali. Sejak itu, kasus terus meningkat dan menyebar ke seluruh provinsi, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Data tentang jumlah pasti orang yang hidup dengan HIV dan AIDS di Indonesia masih sulit diperoleh. Angka yang dilaporkan sering kali hanya mewakili puncak fenomena gunung es, di mana masih banyak kasus yang belum terungkap (Utami, 2017).

Menurut Kementerian Kesehatan RI, infeksi HIV baru di Indonesia menunjukkan penurunan. Estimasi pada tahun 2020 mencatat jumlah orang dengan HIV (ODHIV) sebanyak 543.100, lebih rendah dibandingkan estimasi tahun 2016. Sementara itu, Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) 2018 menunjukkan prevalensi HIV bervariasi menurut kelompok populasi, yaitu 25,8% di antara laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, 28,8% di antara pengguna narkoba suntik, 24,8% di antara waria, dan 5,3% di antara pekerja seks perempuan (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, 2022).

Berdasarkan laporan tingkat provinsi, lima provinsi dengan jumlah kasus HIV tertinggi dari tahun 2010 hingga Maret 2022 adalah DKI Jakarta (76.103 kasus), Jawa Timur (71.909 kasus), Jawa Barat (52.970 kasus), Jawa Tengah (44.649 kasus), dan Papua (41.286 kasus) (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, 2022). Secara kumulatif, lima provinsi dengan jumlah kasus AIDS tertinggi adalah Papua (24.873 kasus), Jawa Timur (21.815 kasus), Jawa Tengah (14.617 kasus), DKI Jakarta (10.913 kasus), dan Bali (9.728 kasus). Di Papua, prevalensi HIV pada populasi umum pada tahun 2017 tercatat sebesar 2,3%. Sebelumnya, pada tahun 2006, survei

menggunakan metode pemeriksaan berbeda menunjukkan prevalensi HIV sebesar 2,4%. Prevalensi ini lebih tinggi pada suku asli Papua sebesar 2,9% dibandingkan non-Papua yang hanya 0,4%, serta lebih tinggi pada pria yang tidak disunat (2,4%) dibandingkan pria yang disunat (0,1%). Pengetahuan komprehensif tentang HIV di Papua masih rendah, hanya 9,2%. Penduduk di dataran rendah memiliki tingkat pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan yang tinggal di daerah pegunungan. Per 30 Juni 2020, jumlah kasus HIV/AIDS tercatat sebanyak 44.664 kasus, terdiri atas 17.538 penderita HIV dan 27.126 penderita AIDS. Berdasarkan jenis kelamin, penderita HIV pada laki-laki berjumlah 7.545 orang dan penderita AIDS 13.443 orang, sementara pada perempuan, penderita HIV mencapai 9.931 orang dan penderita AIDS 13.648 orang. Faktor risiko utama penularan adalah hubungan heteroseksual, dengan total 43.392 kasus, terdiri atas 17.020 kasus HIV dan 26.372 kasus AIDS (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, 2022).

Individu yang baru mengetahui dirinya sebagai ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) sering kali mengalami kesulitan menerima status tersebut. Menurut Hasan dalam Putri (2016), ODHA menghadapi tiga tantangan utama: menghadapi stigma terkait penyakit, menerima kemungkinan waktu hidup yang terbatas, dan menyusun strategi untuk menjaga kondisi fisik serta emosional. WHO mencatat bahwa individu yang baru dinyatakan positif HIV biasanya mengalami perubahan psikososial, termasuk stres, depresi, kurangnya dukungan sosial, serta perubahan perilaku.

Kasus HIV/AIDS yang tinggi pada perempuan menimbulkan kekhawatiran terhadap peningkatan kasus HIV pada anak-anak akibat penularan perinatal, yakni infeksi selama kehamilan atau persalinan. Perempuan dengan HIV/AIDS, terutama yang berusia 25–44 tahun (usia produktif),

menghadapi beban berat dalam rumah tangga, seperti selama kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak (Nur Azizah, 2015). Secara psikologis, ibu dengan HIV/AIDS rentan mengalami kecemasan, stres, depresi, hingga kehilangan rasa percaya diri akibat stigma sosial yang sering mengaitkan mereka dengan perilaku negatif seperti penggunaan narkoba dan pekerjaan seks. Beban ini semakin berat jika ibu baru melahirkan dan anaknya juga dinyatakan positif HIV, yang dapat memicu depresi mendalam selama masa nifas (Azza, 2010).

Masa nifas, yaitu periode pemulihan pascapersalinan, berlangsung selama 6–12 minggu, di mana tubuh ibu kembali ke kondisi sebelum hamil. Pada masa ini, ibu mengalami perubahan fisik dan psikologis, sehingga membutuhkan dukungan tenaga kesehatan dan keluarga untuk mencegah gangguan psikologis patologis (Hutabarat, 2021). Pada ibu nifas dengan HIV, risiko kematian lebih tinggi, dan mereka cenderung tidak memberikan ASI secara langsung kepada anaknya, yang dapat meningkatkan beban psikologis.

Gangguan psikologis yang dialami ibu nifas dengan HIV/AIDS, jika tidak ditangani dengan baik, dapat memperburuk kondisi mereka. Oleh sebab itu, bidan harus mampu mengenali gejala postpartum blues untuk menentukan tindakan yang diperlukan atau merujuk ke ahli psikologi. Tantangan psikologis seperti rasa bersalah karena tidak bisa menyusui atau takut menularkan HIV kepada bayi sering kali diperparah oleh diskriminasi sosial.

Salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah memastikan kehidupan sehat dan sejahtera, termasuk mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030. Upaya ini diwujudkan melalui strategi "Fast Track" yang bertujuan menurunkan infeksi HIV baru, mengurangi kematian akibat

AIDS, serta menghapus stigma dan diskriminasi terkait HIV/AIDS.

Stigma terhadap ODHA terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari keluarga, masyarakat, institusi, hingga nasional. Penelitian Aris Trisanto menunjukkan bahwa di Kota Padang, stigma paling besar berasal dari media massa, diikuti lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Stigma ini umumnya didasari oleh anggapan bahwa HIV/AIDS adalah akibat dari perilaku buruk individu. Stigma tersebut menyebabkan ODHA mengalami hambatan dalam pengobatan dan perawatan, serta menimbulkan dampak sosial, fisik, dan mental.

Wilayah Timur Indonesia menghadapi tantangan unik terkait stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Sikap sinis, pengucilan, dan perlakuan tidak adil masih sering ditemukan di berbagai lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam untuk mengurangi stigma serta mendukung individu yang hidup dengan HIV/AIDS di wilayah ini.

BAB 2

KONSEP HIV/AIDS

A. Defenisi HIV/AIDS

Dalam HIV merupakan singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus*. HIV merupakan retrovirus yang menjangkiti sel-sel sistem kekebalan tubuh manusia dan menghancurkan atau bahkan mengganggu fungsinya. Infeksi virus ini mengakibatkan terjadinya penurunan sistem kekebalan tubuh secara terus-menerus yang akan mengakibatkan penurunan sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh dianggap menurun ketika sistem tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya memerangi infeksi maupun penyakit. Orang yang kekebalan tubuhnya defisien (*Immunodeficient*) menjadi lebih rentan terhadap berbagai ragam infeksi, yang sebagian besar jarang menjangkiti orang yang tidak mengalami defisiensi kekebalan (Kusuma, 2015).

Sementara itu AIDS adalah singkatan dari *Acquired Immnodeficiency Syndrome* dan menggambarkan berbagai gejala dan infeksi yang terkait dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh. HIV telah ditetapkan sebagai penyebab AIDS. Tingkat HIV dalam tubuh dan timbulnya berbagai infeksi tertentu merupakan tolak ukur bahwa infeksi HIV telah berkembang menjadi AIDS (Wahyuningsih, 2017).

HIV merupakan virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4 sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS atau kumpulan berbagai gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh individu akibat HIV. Ketika

individu sudah tidak lagi memiliki sistem kekebalan tubuh maka semua penyakit dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Karena sistem kekebalan tubuhnya menjadi sangat lemah, penyakit yang tadinya tidak berbahaya akan menjadi sangat berbahaya. Orang yang baru terpapar HIV belum tentu menderita AIDS. Hanya saja lama kelamaan sistem kekebalan tubuhnya makin lama semakin lemah, sehingga semua penyakit dapat masuk ke dalam tubuh. Pada tahapan itulah penderita disebut sudah terkena AIDS (Widyasih, 2019).

Individu yang terinfeksi HIV dan AIDS dikenal dengan sebutan ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS). Menurut Mudjahid dalam (Wahyu, 2012) ODHA merupakan singkatan dari orang dengan HIV dan AIDS, dalam hal ini orang yang di dalam tubuhnya terdapat HIV (orang terinfeksi), setelah dilakukan pemeriksaan darahnya baik dengan test Elisa maupun Western Blot. Banyak perubahan yang terjadi dalam diri individu setelah terinfeksi HIV dan AIDS, penyakit yang mereka derita ini mempengaruhi kehidupan pribadi, sosial, belajar, karir dan kehidupan keluarga (Wahyu, 2012).

B. Sejarah HIV/AIDS

Pada awal tahun 1980-an, para peneliti di Amerika Serikat mengamati peningkatan mendadak dua jenis penyakit yang jarang terjadi, yaitu Sarkoma Kaposi (sejenis kanker langka) dan Pneumonia Pneumokista (infeksi paru-paru yang biasanya hanya menyerang penderita gangguan sistem kekebalan tubuh). Kasus-kasus ini ditemukan di kalangan kaum homoseksual, sehingga menarik perhatian komunitas medis (Utami, 2017).

Dalam sebuah buku karya psikiater Dadang Hawari, disebutkan bahwa para dokter di San Francisco menyarankan

pemerintah Amerika Serikat untuk memantau komunitas homoseksual, termasuk aktivitas seksual mereka seperti sodomi, guna mengendalikan penyebaran penyakit tersebut. Namun, rekomendasi ini ditolak karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) setelah mendapat protes dari komunitas homoseksual dan masyarakat umum.

Selanjutnya, penyakit AIDS menyebar lebih luas melalui individu biseksual yang menularkan virus kepada pekerja seks perempuan. Dari pekerja seks ini, virus kemudian menyebar kepada pelanggan laki-laki, yang kemudian menularkan kepada pasangan mereka, termasuk ibu rumah tangga. Penularan ini bahkan dapat memengaruhi bayi yang dikandung oleh ibu yang terinfeksi. Dengan kecepatan penyebaran yang diperkirakan mampu menginfeksi lima orang setiap menit, HIV/AIDS dengan cepat menyebar dari pantai Barat ke pantai Timur Amerika Serikat, lalu meluas ke seluruh dunia. Penyakit ini akhirnya terdeteksi di Indonesia pada tahun 1987, menjadi krisis global dengan dampak fatal yang signifikan (Utami, 2017).

C. Gejala HIV/AIDS

Bersumber dari seseorang terinfeksi HIV, virus ini akan menetap di dalam sel darah putih, terutama sel limfosit T4. Terdapat tiga fase perkembangan infeksi HIV di dalam tubuh, yaitu:

1. Fase Pertama

Pada tahap awal infeksi, umumnya tidak ada gejala yang terlihat. Seseorang dapat membawa virus HIV selama bertahun-tahun tanpa menyadarinya. Hasil tes darah akan menunjukkan keberadaan antibodi hanya setelah tubuh mulai memproduksinya sebagai respons terhadap virus HIV. Proses pembentukan antibodi ini

membutuhkan waktu hingga tiga bulan. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan tes darah segera setelah melakukan hubungan seksual dengan pengidap HIV/AIDS, kemungkinan hasilnya belum mendeteksi virus hingga tiga bulan kemudian.

2. Fase Kedua

Pada tahap ini, penderita mulai mengalami gejala-gejala ringan. Virus HIV mulai berkembang di dalam sel darah putih dan secara bertahap menghancurkannya. Ketika sebagian besar sel darah putih hancur, sistem kekebalan tubuh melemah secara signifikan. Gejala yang mungkin muncul antara lain rasa lelah, penurunan berat badan, batuk, diare, demam, atau keringat berlebih di malam hari.

3. Fase Ketiga

Pada fase ini, gejala menjadi lebih berat karena virus HIV hampir sepenuhnya merusak sistem kekebalan tubuh. Tubuh tidak lagi mampu melawan infeksi atau bakteri yang menyerang. Pada tahap ini, penderita dikategorikan mengidap AIDS. Selain itu, penderita juga berisiko mengalami kanker tertentu, seperti sarkoma Kaposi (kanker pembuluh darah). Secara umum, AIDS sendiri bukan penyebab langsung kematian, melainkan infeksi lain dan kanker yang terjadi akibat lemahnya sistem kekebalan tubuh. Misalnya, flu yang ringan bagi orang sehat dapat menjadi ancaman serius bagi pengidap HIV/AIDS.

Dalam buku Sandiana (dikutip oleh Utami, 2017), dijelaskan bahwa beberapa penderita HIV menunjukkan gejala yang mirip dengan mononukleosis infeksiosa, yakni penyakit yang disebabkan oleh virus Epstein-Barr, salah satu jenis virus herpes. Gejala ini meliputi demam, nyeri

tenggorokan, dan pembesaran kelenjar getah bening. Biasanya, gejala berlangsung selama 3 hingga 14 hari dan sebagian besar akan hilang, meskipun pembesaran kelenjar getah bening sering kali tetap bertahan.

Gejala infeksi HIV dapat muncul beberapa tahun sebelum berkembang menjadi infeksi atau tumor yang khas untuk AIDS. Gejala-gejala tersebut meliputi:

1. Pembengkakan kelenjar getah bening
2. Penurunan berat badan
3. Demam yang datang dan pergi
4. Rasa tidak nyaman atau lelah
5. Kelelahan yang terus-menerus
6. Diare yang berulang
7. Anemia
8. Thrush (infeksi jamur di mulut)

Menurut Sandiana (dalam Utami, 2017), gejala AIDS disebabkan oleh infeksi HIV itu sendiri, infeksi oportunistik, dan kanker. Namun, hanya sedikit penderita AIDS yang meninggal akibat efek langsung dari infeksi HIV. Sebagian besar kematian terjadi karena dampak kumulatif dari berbagai infeksi oportunistik atau tumor. Pada individu tanpa AIDS, organisme atau penyakit umum mungkin hanya berdampak kecil pada kesehatan. Namun, ketika jumlah limfosit CD4+ menurun drastis hingga di bawah 50 sel/mL, penyakit yang dianggap biasa dapat segera menjadi penyebab kematian. Beberapa infeksi oportunistik dan jenis kanker tertentu menjadi tanda khas dari perkembangan AIDS.

1. *Hrush*

Thrush terjadi karena pertumbuhan berlebihan jamur *Candida* di mulut, kerongkongan, atau vagina. Kondisi ini sering menjadi infeksi pertama yang muncul pada penderita HIV. Infeksi jamur vagina yang berulang dan sulit diobati seringkali menjadi tanda awal HIV pada wanita. Namun, kondisi serupa juga dapat terjadi pada wanita sehat akibat berbagai faktor seperti penggunaan pil KB, antibiotik, atau perubahan hormonal.

2. *Pneumonia Pneumokistik*

Pneumonia yang disebabkan oleh jamur *Pneumocystis carinii* adalah salah satu infeksi oportunistik yang sering berulang pada penderita AIDS. Infeksi ini biasanya menjadi infeksi serius pertama yang dialami. Saat ini, belum ditemukan pengobatan atau pencegahan yang efektif, sehingga infeksi ini menjadi penyebab kematian pada penderita HIV.

3. *Toksoplasmosis*

Infeksi kronis yang disebabkan oleh *Toxoplasma* umumnya terjadi pada anak-anak. Jika terjadi reaktivasi *Toxoplasma* dapat menyebabkan infeksi parah, terutama pada otak.

4. *Tuberkulosis (TB)*

Tuberkulosis sering menyerang penderita HIV, dan dapat menjadi lebih mematikan pada mereka. Pada tahap lanjut, penderita TB mengalami penurunan berat badan, demam, dan diare akibat infeksi oleh *Mycobacterium avium*.

5. *Infeksi Saluran Pencernaan*

Infeksi oleh parasite *Cryptosporidium* sering ditemukan pada penderita AIDS, biasanya berasal dari

makanan atau air yang terkontaminasi. Gejalanya meliputi diare berat.

6. Leukoensefalopati Multifokal Progresif

Ini adalah infeksi virus di otak yang memengaruhi fungsi neurologis. Gejala awal meliputi hilangnya kekuatan pada lengan atau tungkai, serta gangguan koordinasi atau keseimbangan. Dalam hitungan hari atau minggu, penderita tidak mampu berjalan atau berdiri. Beberapa bulan kemudian, kondisi ini dapat menyebabkan kematian.

7. Infeksi oleh Sitomegalovirus (CMV)

Infeksi CMV berulang cenderung terjadi pada tahap lanjut HIV/AIDS dan sering menyerang retina, yang dapat menyebabkan kebutaan. Pengobatan dengan obat antivirus dapat membantu mengontrol CMV.

8. *Sarcoma Kaposi*

Sarcoma Kaposi adalah tumor yang tidak menimbulkan rasa sakit, dengan bercak berwarna merah atau ungu yang menonjol di kulit.

9. Kanker

Penderita AIDS juga rentan terhadap kanker kelenjar getah bening (limfoma) yang awalnya muncul di otak atau organ dalam. Wanita dengan AIDS cenderung terkena kanker serviks, sementara pria homoseksual rentan terhadap kanker rektum.

Gejala HIV dan AIDS menurut WHO (Isma, 2023):

1. Gejala Mayor:

Pada tahap awal infeksi HIV, gejala yang muncul meliputi demam, nyeri sendi, pembesaran kelenjar getah bening, dan gejala serupa flu atau mononukleosis. Pada tahap tanpa gejala, penderita tampak sehat tetapi tetap menjadi sumber penularan.

2. Gejala Minor:

Ketika infeksi HIV berkembang menjadi AIDS (dalam waktu 1-5 tahun), gejala infeksi oportunistik seperti *Pneumocystis carinii* (PCC) menjadi umum. Infeksi lainnya meliputi meningitis, kandidiasis, sitomegalovirus, mikrobakterial, dan infeksi atipikal.

Menurut Lubis (dalam Isma, 2023), beberapa penderita menunjukkan gejala awal seperti mononukleosis infeksius beberapa minggu setelah terinfeksi. Gejala ini meliputi demam, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, dan rasa tidak nyaman, yang berlangsung selama 3-14 hari. Sebagian besar gejala akan hilang, meskipun pembesaran kelenjar getah bening sering bertahan.

Selama beberapa tahun, gejala lainnya mungkin tidak muncul, namun jumlah virus dalam darah dan cairan tubuh tetap tinggi, sehingga penderita dapat menularkan infeksi. Dalam beberapa bulan setelah terinfeksi, gejala ringan dapat muncul secara berulang tanpa menunjukkan tanda-tanda AIDS yang sebenarnya. Gejala infeksi HIV dapat muncul bertahun-tahun sebelum berkembang menjadi infeksi atau tumor yang khas pada AIDS.

D. Penularan HIV/AIDS

Menurut WHO (dalam Isma, 2023), HIV dapat ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh dari individu yang terinfeksi, seperti darah, air susu ibu (ASI), semen, dan cairan vagina. Penularan juga dapat terjadi dari ibu ke anak selama masa kehamilan dan proses persalinan. Namun, HIV tidak dapat menular melalui interaksi sehari-hari seperti mencium, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagi benda pribadi, makanan, dan air. Tiga cara utama penularan HIV/AIDS:

1. Melalui hubungan seksual.

2. Paparan terhadap darah, produk darah, atau organ dan jaringan yang terinfeksi.
3. Penularan dari ibu ke anak.

Dilihat dari faktor risiko, perilaku seksual berisiko melalui hubungan heteroseksual merupakan penyebab paling umum, dengan angka penularan sebesar 56%. Cairan tubuh yang berperan dalam penularan HIV. HIV terdapat dalam cairan tubuh seperti darah, semen, cairan vagina, dan ASI. Penularan hanya terjadi jika cairan terkontaminasi ini masuk ke aliran darah seseorang. Enam jalur penularan HIV:

1. Transfusi darah: Penularan melalui transfusi darah atau produk darah yang sudah terkontaminasi HIV.
2. Jarum suntik: Penggunaan jarum suntik bekas yang terkontaminasi, baik oleh pengguna narkoba suntik maupun karena kecelakaan medis, misalnya petugas kesehatan yang tidak sengaja tersuntik.
3. Hubungan seksual tidak aman: Penularan terjadi melalui hubungan seksual yang tidak terlindungi dengan orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA), baik pada hubungan heteroseksual, homoseksual, maupun seks oral. Virus masuk ke aliran darah melalui luka kecil atau membran mukosa di penis, vagina, atau mulut.
4. Transplantasi organ atau jaringan: Penularan melalui transplantasi organ atau jaringan yang berasal dari individu yang terinfeksi HIV.
5. Penularan ibu ke anak: HIV dapat menular dari ibu yang terinfeksi ke anak selama kehamilan, persalinan, atau melalui ASI.
6. Masa kehamilan, persalinan, dan menyusui: Penularan dapat terjadi pada bayi yang dikandung oleh ibu positif HIV, melalui persalinan normal, atau saat menyusui dengan ASI.

E. Pencegahan HIV/AIDS

Pencegahan penyebaran dan penularan HIV/AIDS sangat bergantung pada perubahan perilaku berisiko. Menurut Nurchasanah (dalam Utami, 2017), beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah epidemi HIV/AIDS adalah:

1. Kesetiaan pada pasangan

Menjaga kesetiaan kepada pasangan dengan tidak bergonta-ganti pasangan.

2. Pencegahan penularan dari ibu ke anak

Penularan HIV dari ibu ke anak dapat terjadi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Namun, jika ibu hamil yang terinfeksi HIV mendapatkan pengobatan antivirus secara dini dan rutin selama kehamilan, risiko penularan pada bayi dapat berkurang drastis. Tidak semua bayi yang lahir dari ibu HIV positif akan tertular. Dari 100 ribu ibu positif HIV yang melahirkan, sekitar 30 ribu bayi mungkin akan tertular, dengan rincian: 5 ribu saat kehamilan, 15 ribu saat persalinan, dan 10 ribu melalui ASI. Oleh karena itu, penting bagi setiap ibu hamil untuk mengetahui status HIV-nya.

3. Konseling

Konseling menjadi elemen penting dalam penanganan epidemi AIDS. Orang yang terinfeksi HIV membutuhkan informasi, dukungan, dan saran untuk menghadapi kondisi mereka. Konseling individu tentang cara merawat diri dan orang lain dapat membantu mencegah penyebaran HIV/AIDS.

4. Tes mandiri

Bagi mereka yang aktif melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, tes HIV secara rutin sangat disarankan.

Menurut Silitonga (dalam Utami, 2017), ada beberapa poin penting bagi masyarakat dan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) untuk mengendalikan penularan HIV/AIDS:

1. Penyakit seumur hidup

ODHA akan hidup dengan penyakit ini seumur hidup, dengan risiko berkembangnya berbagai komplikasi di masa depan. Meskipun tanpa gejala, ODHA dapat menularkan virus. Wanita dengan HIV positif atau pasangan HIV positif memiliki risiko tinggi, termasuk risiko pada janin jika hamil.

2. Larangan donor

ODHA tidak boleh mendonorkan darah, plasma, organ tubuh, jaringan, atau sperma.

3. Risiko penularan melalui hubungan seksual dan jarum suntik

Virus HIV dapat menular melalui hubungan seksual (anal, oral, atau vagina) dan penggunaan jarum suntik bersama. Penggunaan kondom dapat mengurangi risiko meskipun tidak sepenuhnya mencegah penularan.

4. Barang pribadi

Barang pribadi seperti sikat gigi, alat cukur, atau alat lain yang dapat bersentuhan dengan darah atau cairan tubuh sebaiknya tidak digunakan bersama. Alat medis seperti jarum akupunktur atau kedokteran gigi harus disterilisasi atau dibuang dengan aman setelah digunakan.

5. Pemberitahuan kepada tenaga medis

ODHA perlu memberi tahu tenaga medis saat menjalani pemeriksaan atau perawatan agar penanganan dilakukan dengan lebih hati-hati.

6. Uji antibodi HIV

Uji antibodi perlu dilakukan pada orang yang berkontak erat dengan ODHA, seperti pasangan, anak, atau anggota keluarga.

7. Hati-hati dalam profesi Kesehatan

ODHA yang bekerja di bidang kesehatan harus sangat berhati-hati saat menangani prosedur invasif agar tidak menularkan virus.

8. Anak dengan HIV

Anak-anak dengan HIV tidak perlu berhenti sekolah, tetapi perhatian khusus diperlukan untuk kebiasaan yang dapat menyebabkan luka atau kontak darah, seperti menggigit teman atau jatuh hingga berdarah.

F. Pengobatan HIV/AIDS

Pengobatan HIV dan AIDS dengan terapi antiretroviral (ARV) membutuhkan partisipasi aktif dari ODHA (Orang dengan HIV/AIDS), keluarga, dan masyarakat untuk mendukung kehidupan yang lebih normal. Terapi ARV berfungsi memulihkan sistem kekebalan tubuh sehingga mampu melawan infeksi oportunistik (IO), meningkatkan kualitas hidup, serta mengurangi risiko penyakit dan kematian akibat HIV/AIDS (Kurniawati, 2022).

Kepatuhan terhadap pengobatan sangat penting. Dukungan dari masyarakat, kader, LSM, populasi kunci, dan ODHA sendiri diperlukan untuk menyampaikan pesan-pesan konsisten tentang pentingnya kepatuhan minum obat. Beberapa upaya pengobatan yang dapat dilakukan bersama meliputi:

1. Memfasilitasi rujukan agar ODHA memperoleh layanan kesehatan dasar dan pengobatan ARV.
2. Meningkatkan rujukan untuk diagnosis dan pengobatan IO serta penyakit terkait HIV, termasuk tuberkulosis (TB).

3. Mendukung ODHA dalam mendapatkan pengobatan profilaksis IO serta tata laksana Hepatitis B dan C.

4. Mencegah, mengobati, dan menangani hubungan TB-HIV

Terapi antiretroviral (ART) terapi untuk mengobati infeksi HIV dengan beberapa obat. Obat yang digunakan melawan HIV dan AIDS disebut sebagai obat antiretroviral (ARV), karena digunakan untuk melawan HIV dan AIDS yang merupakan retrovirus. ARV tidak dapat membunuh virus tersebut, namun ART dapat memperlambat laju perkembangan virus didalam tubuh manusia (Kurniawati, 2022).

Terapi ART tidak hanya terdiri atas pemberian obat ARV saja, namun termasuk dukungan medis dan sosial untuk membantu mengatasi efek samping obat, menjaga kepatuhan dan kesetiaan pada terapi. Saat ini ada 5 (lima) golongan ARV yang digunakan untuk mengobati HIV dan AIDS yaitu (Kurniawati, 2022):

1. Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI)

Menghambat perubahan bahan genetik HIV dari RNA menjadi DNA. Contohnya: Lamivudine (3TC), Abacavir (ABC), Zidovudine (AZT), Didanosine (ddI), Emtricitabine (FTC), dan Tenofovir (TDF).

2. Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NNRTI)

Menghambat siklus hidup HIV dengan mekanisme lain. Contohnya: Delaviradine (DLV), Efavirenz (EFV), Etravirine (ETV), Nevirapine (NVP), dan Rilpivirine (RPV).

3. Protease Inhibitor (PI)

Menghambat pematangan virus baru. Contohnya: Atazanavir (ATV), Darunavir (DRV), Fosamprenavir (FPV), Lopinavir (LPV), Ritonavir (RTV), dan Tipranavir (TPV).

4. Fusion Inhibitor

Mencegah HIV menempel pada sel target. Contohnya: Enfuvirtide (T-20) dan Maraviroc (MVC).

5. Integrase Inhibitor (INI)

Mencegah integrasi DNA HIV dengan DNA sel inang. Contohnya: Raltegravir (RGV) dan Elvitegravir (EGV).

AntiRetroviral Terapi (ARV) pada umumnya dipakai dalam gabungan 3 (tiga) atau lebih ARV dari golongan yang berbeda. Hal ini disebut dengan terapi kombinasi ARV atau ART. ART bekerja jauh lebih baik dibandingkan hanya menggunakan satu jenis ARV. Produsen ARV terus berupaya membuat obat ARV lebih mudah dikonsumsi. Hingga saat ini sudah menggabungkan dua atau lebih jenis obat dalam satu pil.

Di Indonesia ARV yang tersedia telah digunakan oleh sebagian ODHA dan membawa dampak positif bagi keberlangsungan hidup ODHA. Namun sebagian ODHA juga mengalami kegagalan terapi dikarenakan pengaruh efek samping penggunaan ARV. Umumnya, semakin tinggi takaran obat yang dipakai, semakin berat efek sampingnya. Jika tubuh lebih kecil dari pada rata-rata, maka akan mengalami lebih banyak efek samping. Jika tubuh menguraikan obat lebih lambat dari yang sewajarnya, tingkat obat dalam darah akan dapat lebih tinggi, dan hal ini lebih mungkin mengakibatkan efek samping (Kurniawati, 2022).

Beberapa efek samping menjadi semakin buruk bila obat yang bersangkutan dipakai dengan perut kosong dan dapat lebih memburuk apabila obat dipakai dengan makanan atau minuman berlemak (misalnya susu). Berbagai macam gejala yang timbul saat efek samping muncul yaitu tubuh akan mengalami sakit kepala, darah tinggi, atau

seluruh badan terasa tidak enak. Namun seiring berjalannya waktu gejala yang timbul diakibatkan efek samping akan mulai membaik dan hilang.

Apabila saat mulai penggunaan ARV tubuh mengalami efek samping maka jangan berhenti menggunakan obat apapun, melewati atau mengurangi dosisnya, tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter.

BAB 3

STIGMA DALAM KONTEKS HIV/AIDS

A. Defenisi Stigma

Dalam bahasa Yunani, kata *stigma* berarti 'tato', yaitu sebuah tanda permanen yang dibuat dengan besi panas dan ditorehkan pada tubuh seseorang. Tanda ini berfungsi sebagai penanda bahwa individu tersebut telah melakukan perbuatan yang dianggap tidak bermoral. Dengan demikian, stigma sering kali memberikan kesan bahwa orang yang bersangkutan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma atau aturan masyarakat.

Secara harfiah stigma mengacu pada beberapa bentuk dari tanda atau noda, seperti yang dikemukakan oleh Osberne dalam Page "*Stigma dates back to the Greek word for 'tattoo-mark', a brand made with a hot iron and impressed on people to show that they were devoted to the services of the temple or, on the opposite spectrum of behavior, that they were criminals or runaway slave*". Pendapat lain mengenai stigma dikemukakan oleh R.W English dalam Page "*In the final analysis, stigma might best be considered to be the negative perceptions and behaviors of so-called normal people to all individuals who are different from themselves*".

Dalam pandangan sosiologi yang lebih umum menurut Kando dalam Page menjelaskan bahwa stigma dapat mengacu pada sifat yang meragukan dan tidak pantas. Goffman berpendapat bahwa stigma merupakan atribut, perilaku, atau reputasi sosial yang mendiskreditkan dengan

cara tertentu. Stigma berasal dari pikiran sosial seorang individu atau masyarakat yang memercayai sesuatu merupakan akibat dari perilaku amoral yang tidak dapat diterima oleh Masyarakat.

United Nations Programme on HIV and AIDS (UNAIDS) suatu program HIV dan AIDS bersama PBB mendefinisikan stigma terkait dengan HIV sebagai ciri negatif yang diberikan pada seseorang sehingga menyebabkan tindakan yang tidak wajar dan tidak adil terhadap orang tersebut berdasarkan status HIV-nya. Sedangkan stigma terkait AIDS adalah segala persangkaan, penghinaan dan diskriminasi yang ditujukan kepada ODHA serta individu, kelompok atau komunitas yang berhubungan dengan ODHA tersebut. Stigma dalam kaitan HIV dan AIDS diartikan sebagai cap buruk yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS. Cap buruk ini berasal dari seseorang, kemudian menyebar ke orang lain dalam masyarakat sehingga menjadi stigma sosial. Stigma dan diskriminasi terkait dengan HIV dan AIDS memiliki berbagai bentuk dan dimanifestasikan dalam berbagai tingkat negara, masyarakat dan individu dan juga dalam berbagai konteks.

Konsep stigma yang dikembangkan melalui konsep yang diuraikan oleh Erving Goffman (1963), yang mendefinisikan stigma sebagai tanda atau atribut yang merendahkan status seseorang di mata masyarakat (Chambers et al., 2015). Menurut Aris Tristanto (2022) Stigma terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) tercermin dalam sikap sinis, rasa takut yang berlebihan, dan pengalaman negatif terhadap ODHA. Banyak orang berpendapat bahwa individu yang terinfeksi HIV dan AIDS seharusnya menerima hukuman akibat perbuatannya sendiri. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa ODHA bertanggung jawab atas

penularan HIV dan AIDS (Aris Tristanto et al., 2022). Walaupun stigma yang terkait dengan kesehatan telah terkait dengan kondisi kesehatan lain seperti penyakit mental, kanker, dan infeksi menular seksual lainnya, sebagian besar literatur terkait stigma penyakit dalam kurun waktu belakangan ini difokuskan pada stigma dan diskriminasi yang terkait dengan HIV dan AIDS (stigma terkait HIV) (Restall et al., 2023). Jalur penularan HIV turun memperburuk situasi sosial, di mana HIV selain terjadi pada Wanita, juga lebih banyak pada perilaku seks Lelaki Seks Lelaki (LSL) (Rafiq, 2019). Stigma yang sering muncul dalam bentuk diskriminasi atau perlakuan tidak adil oleh individu lain (yang tidak terinfeksi HIV) merupakan salah satu dampak negatif utama yang dihadapi oleh orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) di berbagai lokasi (Chaudoir, 2015).

Stigma terhadap ODHA, muncul seiring dengan merebaknya penularan virus HIV dan AIDS itu sendiri. UNAIDS menjelaskan bahwa stigma terkait dengan HIV merupakan ciri negatif yang diberikan pada seseorang sehingga menyebabkan tindakan yang tidak wajar dan tidak adil terhadap orang tersebut berdasarkan status HIV-nya. Sedangkan stigma terkait AIDS adalah segala persangkaan, penghinaan dan diskriminasi yang ditujukan kepada ODHA serta individu, kelompok atau komunitas yang berhubungan dengan ODHA tersebut.

Zhou dalam tulisannya berpendapat bahwa stigma HIV dan AIDS merupakan penyimpangan individu dari standar normalitas yang diterima secara sosial, dimana hal ini mencakup penyimpangan moralitas, pergaulan bebas dan penyalahgunaan obat terlarang. Oleh sebab itu ODHA secara sosial dikonstruksikan sebagai orang yang sangat berbeda sehingga dapat mengancam masyarakat umum. Dari dua

pendapat tersebut maka stigma dalam kaitan HIV dan AIDS diartikan sebagai cap buruk yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS. Stigma terkait HIV dan AIDS terjadi karena tiga sumber yaitu:

1. Ketakutan. semua tahu HIV dan AIDS adalah penyakit infeksi yang tidak ada obat untuk menyembuhkan.
2. Moril. penyakit HIV dan AIDS sering terkait dengan seks berisiko dan penyalahgunaan obat terlarang, kutukan Tuhan dengan alasan bahwa ODHA adalah orang-orang yang telah melanggar norma agama.
3. Ketidak acuan oleh media masa dan adanya ketakutan dan pikiran moril pembaca. Selain itu stigma terkait dengan HIV dan AIDS memiliki berbagai bentuk dan dimanifestasikan dalam berbagai tingkat-negara, masyarakat dan individu-dan juga dalam berbagai konteks.

Isolasi sosial, penyebaran status HIV dan penolakan dalam pelbagai lingkup kegiatan kemasyarakatan seperti dunia pendidikan, dunia kerja, dan layanan kesehatan merupakan bentuk stigma yang banyak terjadi. Tingginya penolakan masyarakat dan lingkungan akan kehadiran orang yang terinfeksi HIV dan AIDS menyebabkan sebagian ODHA harus hidup dengan menyembunyikan status.

1. Sudut Pandang Stigma

a. Stigma Masyarakat

Stigma masyarakat merupakan perasaan bahwa seseorang atau kelompok merasa mereka lebih unggul dari yang lain dan menyebabkan seseorang atau kelompok lain dikucilkan secara sosial yang pada akhirnya mengarah kepada terjadinya ketimpangan sosial.

Proses terjadinya suatu stigma masyarakat dimulai dari individu atau masyarakat memberikan label (labelling) pada individu atau kelompok tertentu atas karakteristik atau perbedaan yang dimiliki. Dari label tersebut mendorong munculnya keyakinan individu atau masyarakat terhadap individu atau kelompok yang berbeda atas budaya yang dimiliki. Keyakinan ini kemudian menempatkan individu atau kelompok tersebut ke dalam kategori yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya sehingga terjadi pemisahan. Pada akhirnya, individu atau kelompok yang berbeda mendapatkan perlakuan yang berbeda (diskriminasi) dari masyarakat.

Menurut Major dan O'Brien, mekanisme terjadinya stigma terbagi menjadi empat yaitu:

- 1) Adanya perlakuan negatif dan diskriminasi secara langsung yang artinya terdapat pembatasan pada akses kehidupan dan diskriminasi secara langsung sehingga berdampak pada status sosial, psychological well-being dan kesehatan fisik;
 - 2) Stigma menjadi sebuah proses melalui konfirmasi harapan atau *self fulfilling prophecy*;
 - 3) Stigma dapat menjadi sebuah proses melalui aktivasi stereotip otomatis secara negatif pada suatu kelompok;
 - 4) Terjadi ancaman terhadap identitas dari individu.
- b. Stigma pada diri sendiri (*self stigma*)
- Stigma pada diri sendiri (*self stigma*) adalah konsekuensi dari orang yang distigmakan menerapkan stigma untuk diri mereka sendiri. Menurut Corrigan dan Rao, stigma diri juga sering disamakan dengan penerimaan diri yang negatif, yang mana pengakuan

seseorang bahwa publik memiliki prasangka buruk dan akan memberikan stigma terhadap mereka. Secara khusus, mereka akan merasakan devaluasi atau merendahkan diri dan diskriminasi yang menyebabkan menurunnya harga diri dan keyakinan individu mengenai kemampuan dirinya dalam melakukan tugas atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu atau lebih dikenal dengan efikasi diri. Stigma yang menilai negatif terhadap diri sendiri merupakan salah satu faktor yang dapat melanggengkan diskriminasi. Sebab, dengan berkurangnya rasa percaya diri dan penerimaan terhadap diri sendiri melalui cara berpikir akan menciptakan pesimisme atau kegagalan terhadap individu itu sendiri, seperti perasaan kurang layak mendapat kesempatan atau peluang yang ada sehingga melemahkan usaha pada kesempatan atau peluang tersebut.

Dalam konsep stigma pada diri sendiri terdapat pula konsep "*The Why Try Effect*" atau efek "mengapa mencoba". Efek ini merupakan konsekuensi dari stigma diri dimana stigma diri mengganggu pencapaian tujuan hidup seseorang. Stigma diri berfungsi sebagai penghalang untuk mencapai tujuan hidup. Namun demikian, harga diri dan efikasi diri juga sebenarnya dapat mengurangi akibat berbahaya dari stigma pada diri.

- c. Hubungan Stigma masyarakat dengan Stigma pada diri sendiri (*self stigma*)

Stigma masyarakat berhubungan erat dengan stigma pada diri sendiri karena stigma pada diri akan terbentuk pada saat seseorang yang meyakini bahwa stigma yang diberikan masyarakat terhadap dirinya

adalah sebuah kebenaran. Pada umumnya, orang dengan kondisi seperti ini sadar akan fenomena yang ada di Masyarakat tentang kondisi mereka. Dengan demikian tahap ini disebut dengan tahap Kesadaran (*Awareness*). Orang ini kemudian setuju bahwa stereotip negatif tentang mereka di masyarakat itu benar, tahap ini disebut dengan tahap Persetujuan (*Agreement*). Selanjutnya, orang tersebut setuju bahwa stereotip ini berlaku untuk dirinya sendiri atau disebut dengan tahap Aplikasi (*Apply*). Hal ini menyebabkan kerugian, penurunan harga diri dan *self-efficacy* atau efikasi diri yang signifikan, sehingga tahap ini menjadi tahap akhir stigma diri yang disebut Kerugian (*Harm*). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Aris trisanto tahun 2022, HIV dan AIDS masih memiliki citra yang menakutkan di kalangan masyarakat khususnya pada ODHA sendiri, selain karena faktor cara penularannya, AIDS dianggap sebagai vonis hukuman mati. Orang yang pertama kali terdiagnosis HIV dan AIDS seringkali merasa depresi, takut, gundah dan putus asa. Hal ini menyebabkan ODHA melakukan stigma dan diskriminasi terhadap dirinya sendiri. Kejadian ini masih sering dijumpai pada ODHA di Kota Bandung, terutama pada ODHA yang berusia lebih muda yaitu sekitar 15-24 tahun. Ketika pertama kali terdiagnosis HIV, banyak ODHA merasa cemas tidak akan lagi diterima di keluarga, lingkungan dan masyarakatnya serta ketakutan untuk menyongsong masa depan sehingga ODHA tidak lagi mau bergaul, tidak mau melanjutkan pendidikan atau cenderung melakukan bunuh diri. Pada ODHA yang sudah lebih

tua, cenderung tidak mengalami stigma sebab telah mencapai tingkat keamanan dan kepercayaan diri

B. Dampak Stigma pada Individu

Stigma menghambat ketaatan terhadap pengobatan, penggunaan layanan yang tidak memadai, dan pada akhirnya menyebabkan apatis terhadap tingkat penyakit dan kematian (Deepa Rao et al., 2012). Individu yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) telah lama menghadapi stigma dan diskriminasi, yang diperparah oleh isu-isu yang terkait dengan gender, seksualitas, dan budaya. Stigma terkait HIV tidak hanya menghalangi ODHA dalam mencari konseling dan tes sukarela, tetapi juga mencegah mereka untuk membuka status HIV/AIDS mereka. Sebagai akibatnya, ODHA mengalami kesulitan dalam mengakses obat antivirus yang tersedia dan menjadi rentan terhadap perilaku seksual berisiko (Darmawan & Permatasari, 2022). Selama beberapa tahun terakhir, stigma terhadap HIV/AIDS telah menjadi fokus utama dari banyak penelitian. Meskipun telah ada berbagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi prevalensi dan dampak stigma ini, sikap negatif masyarakat masih menjadi hambatan yang signifikan bagi upaya kesehatan masyarakat dalam memerangi dan menanggulangi epidemi HIV (Fasoulakis, 2017).

UNAIDS membagi stigma terkait HIV dan AIDS menjadi tiga kategori, yakni stigma instrumental, stigma simbolis, dan stigma kesopanan. Stigma instrumental merupakan stigma yang terkait dengan ketakutan terhadap aspek-aspek yang terkait dengan penyakit yang dapat menyebabkan kematian dan penularan. (Chambers et al., 2015), Maksudnya adalah stigma muncul akibat dari factor penyebab dan akibat dari HIV dan AIDS, sebagai contoh

masyarakat memberi stigma pada ODHA sebagai orang yang akan mati.

Stigma simbolis adalah stigma terkait penggunaan HIV dan AIDS untuk mengekspresikan sikap terhadap kelompok sosial atau gaya hidup tertentu yang dianggap berhubungan dengan penyakit tersebut, seperti seseorang menjadi ODHA karena pergaulan pada masa lalu yang suka berganti-ganti pasangan. Sedangkan stigma kesopanan adalah hukuman sosial atas orang yang berhubungan dengan isu HIV dan AIDS atau orang yang positif HIV, seperti ODHA dikeluarkan dari tempat kerja dengan tidak hormat.

Stigma juga memiliki dimensi tersendiri. Dimensi stigma HIV dan AIDS sama dimensi stigma pada umumnya. Jones dalam Link dan Phelan mengidentifikasi dimensi dari stigma menjadi enam, yaitu:

1. *Concealability*, yakni sampai sejauh mana suatu kondisi dapat disembunyikan atau tidak tampak oleh orang lain. Contoh: seberapa mampu ODHA menyembunyikan identitasnya dihadapan keluarga dan masyarakat;
2. *Course*, menjelaskan bagaimana kondisi orang yang mendapatkan stigma berubah dari waktu ke waktu. Contoh: kemampuan ODHA untuk bertahan hidup;
3. *Strains*, menjelaskan bagaimana hubungan interpersonal menjadi tegang. Contoh: Hubungan ODHA dengan lingkungan sekitar ODHA dengan mengetahui status ODHA.
4. *Aesthetic Qualities*, menjelaskan bagaimana penampilan seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi stigma. Contoh: Seorang ODHA mampu untuk tampil biasa ditengah stigma yang dialaminya;
5. *Cause*, menjelaskan apakah seseorang mengalami stigmatisasi karena bawaan dari lahir atau setelah dewasa.

Contoh: perbedaan sikap dalam menerima diri karena HIV dapat dari orang tua, dengan sikap ODHA yang terinfeksi HIV karena perbuatan disaat dewasa;

6. *Peril*, menjelaskan kemungkinan keberbahayaan pada orang lain terkait dengan kondisi terstigmatisasi. Contoh: pengaruh ODHA kepada keluarganya.

Bagi individu yang terpapar penyakit ini, menjalani kehidupannya menjadi sulit karena perubahan fisik yang terkait dengan perkembangan penyakit. Pandangan dan sikap masyarakat terhadap individu tersebut umumnya masih belum dapat menerima, penuh ketakutan, menilai buruk, yang berpotensi menyebabkan isolasi, penolakan, dan diskriminasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tekanan psikologis pada penderita. Sekitar 50% pria dan wanita mengalami stigma dan tindakan diskriminatif terkait dengan status HIV di 35% negara di seluruh dunia.

Stigma masyarakat terjadi ketika pandangan umum setuju dengan stereotipe negatif terhadap seseorang, seperti orang yang mengalami gangguan mental, kecanduan, dan sebagainya. Stigma memiliki dampak serius terhadap kehidupan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), menciptakan gejala depresi dan kecemasan, perasaan sedih, rasa bersalah, dan perasaan rendah diri. Selain itu, stigma juga dapat merugikan kualitas hidup ODHA dengan membatasi akses dan pemanfaatan layanan kesehatan, serta mengurangi kepatuhan terhadap pengobatan antiretroviral (ARV). Angka kejadian HIV/AIDS mengalami kenaikan sebesar 64,50% pada tahun 2019 dan menyebar secara meluas, mencakup wilayah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, perhatian dan penanganan yang menyeluruh diperlukan, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat internasional serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (Handayani et al., 2020).

Stigma terkait kesehatan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat yang hidup dengan keragaman kondisi kesehatan dan merusak respon kesehatan masyarakat untuk mengekang beban penyakit tersebut. Apabila masalah stigma terhadap ODHA terus didiamkan dan tidak diselesaikan dengan segera maka stigma akan berdampak langsung dalam proses pengobatan dan perawatan ODHA. Menurut Carr dan Gramling penolakan yang disebabkan oleh stigma ini mempengaruhi akses ke perawatan kesehatan, kepatuhan minum obat, interaksi sosial, dan dukungan sosial. Hal ini akan lebih buruk lagi bila dibarengi dengan persepsi negatif di kalangan ODHA itu sendiri tentang keberadaannya, sehingga mereka menjadi pasrah dan semakin tertekan serta kehilangan rasa percaya diri.

C. Pengalaman Stigma yang Dialami Ibu Postpartum dengan HIV/AIDS

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Arum Surya Utami tahun 2024 menunjukkan bahwa kedua partisipan mengalami lonjakan perasaan yang campur aduk selama postpartum. Kedua partisipan merasa takut dan cemas secara berlebih karena HIV/AIDS yang dideritanya. Mereka sangat takut penyakit tersebut menular kepada bayi yang baru mereka lahirkan. Perasaan ibu postpartum dengan HIV/AIDS dipenuhi dengan rasa takut dan cemas yang berlebih. Hal tersebut disebabkan dengan keadaan ibu yang baru saja melahirkan yang memerlukan adaptasi dengan situasi baru dan ditambah lagi kondisi HIV/AIDS yang diderita yang menambah kekhawatiran ibu postpartum dapat menularkan kepada bayinya. Peneliti berpendapat bahwa rasa takut dan cemas yang dialami kedua partisipan

sangat wajar. Karena sebagai seorang ibu postpartum dengan penyakit HIV/AIDS pasti tidak ingin bayi yang baru saja mereka lahirkan tertular penyakit tersebut. Hal tersebut harus diimbangi dengan dukungan orang-orang terdekat dari partisipan agar partisipan merasa tenang dan tidak mengalami gangguan psikologi secara berlebihan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Violin Irene Ninef Tahun 2023 stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS di masyarakat terpencil dipengaruhi oleh proses sosial dan budaya yang mengakar. Norma-norma tradisional seringkali menciptakan isolasi sosial, dengan keyakinan bahwa kondisi ini adalah kutukan moral. Dalam konteks ini, muncul dilema moral karena beberapa partisipan masih terpaksa pada pandangan bahwa HIV/AIDS berasal dari perilaku amoral. Hal ini sejalan dengan pendapat Aris Tristante (2022), HIV dan AIDS masih memiliki citra yang menakutkan di kalangan masyarakat khususnya pada ODHA sendiri, selain karena faktor cara penularannya, AIDS dianggap sebagai vonis hukuman mati. Orang yang pertama kali terdiagnosis HIV dan AIDS seringkali merasa depresi, takut, gundah dan putus asa. Hal ini menyebabkan ODHA melakukan stigma dan diskriminasi terhadap dirinya sendiri. Kejadian ini masih sering dijumpai pada ODHA di Kota Bandung, terutama pada ODHA yang berusia lebih muda yaitu sekitar 15-24 tahun. Ketika pertama kali terdiagnosis HIV, banyak ODHA merasa cemas tidak akan lagi diterima di keluarga, lingkungan dan masyarakatnya serta ketakutan untuk menyongsong masa depan sehingga ODHA tidak lagi mau bergaul, tidak mau melanjutkan pendidikan atau cenderung melakukan bunuh diri. Pada ODHA yang sudah lebih tua, cenderung tidak mengalami stigma sebab telah mencapai tingkat kemapanan dan kepercayaan diri.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zang Chunpeng (2014) menyebutkan bahwa stigma terkait HIV berakar kuat pada budaya, oleh karena itu penting untuk menyelidikinya dalam konteks budaya. Akibat dari perilaku budaya terhadap HIV/AIDS, ODHA dapat dan akan menginternalisasikan perasaannya sebagai stigma negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Faktor budaya yang sangat menonjol (yang menjadi pusat perhatian) dalam stigma diri. Masalah khusus ini tidak berbeda dengan penelitian sebelumnya, dengan mengatakan bahwa stigma diri dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang distigmatisasi pada masyarakatnya. Hal ini menyebabkan terhambatnya intervensi budaya yang bertujuan untuk mengurangi stigmatisasi diri dan meningkatkan kesehatan mental di antara kelompok yang terstigmatisasi.

Stigma masih menjadi isu penting karena seringkali menjadi kendala dalam Upaya menurunkan prevalensi HIV/AIDS. Oleh karena itu perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi hal ini. Pada sebuah penelitian oleh Wingiton, J.M. et al. (2021) menunjukkan bahwa stigma dan diskriminasi terkait HIV masih kerap ditemukan pada suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan sebuah strategi dimana strategi pengurangan stigma layanan kesehatan harus bersifat multilevel dan melibatkan semua anggota staf, bukan hanya profesional kesehatan, dalam pelatihan dan penyusunan kebijakan, menggunakan metode partisipatif dan melibatkan ODHA dalam pengembangan pelatihan, dan secara berkala memantau stigma di kalangan petugas kesehatan (Nyblade et al., 2009). Bisa dibayangkan, tambahan, perubahan tingkat struktural yang akan membuat layanan tambahan yang memberikan

dukungan sebaya dan isolasi, perawatan psikologis, dan manajemen kondisi kronis tersedia di mana pengobatan dan perawatan HIV juga ditawarkan, dan memastikan lingkungan tersebut bebas stigma, dapat membantu menghilangkan kebutuhan yang belum terpenuhi di area tersebut. Stigma terhadap ODHA dalam penelitian ini adalah sikap dan perilaku negatif seseorang apabila berhadapan dengan ODHA pada masyarakat perkotaan dan pedesaan Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan 9 dari 10 (92%) wanita dan 84 persen pria kawin bersikap diskriminatif terhadap orang yang terinfeksi HIV. Sikap diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi HIV ini kemungkinan besar berkaitan dengan ketidaktahuan seseorang tentang mekanisme penularan HIV. Kesalahpahaman atau kurangnya pengetahuan tentang HIV-AIDS seringkali berdampak pada ketakutan dan penolakan masyarakat terhadap ODHA.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akmal tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan Stigma atau Diskriminasi terhadap Orang dengan HIV/AIDS pada Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Sulawesi Selatan. Stigma dan diskriminasi terhadap ODHA masih banyak terjadi dimasyarakat pedesaan. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan hampir separuh dari responden (49,7%) memiliki sikap negatif terhadap ODHA. Bentuk stigma yang terjadi dimasyarakat seperti tidak makan makanan yang disediakan atau dijual oleh penderita HIV, tidak membolehkan anaknya bermain bersama dengan anak penderita HIV, tidak mau menggunakan toilet bersama, ataupun menolak untuk tinggal dekat dengan orang yang menunjukkan gejala penderita HIV/AIDS. Apabila dalam keluarga terdapat penderita HIV, mereka takut tidur bersama dan tidak bersedia merawat seperti menyiapkan

makanan dan membersihkan peralatan makan, ataupun duduk dekat dengan orang-orang terinfeksi HIV.

Stigma juga muncul karena ketidaktahuan masyarakat tentang informasi HIV, khususnya proses penularan HIV dan cara pencegahannya termasuk dalam penggunaan kondom. Stigma adalah penghalang terbesar untuk mencegah penularan dan pengobatan HIV. Selain itu, stigma terhadap ODHA bisa menyebabkan orang yang memiliki gejala atau diduga menderita HIV tidak mau melakukan tes untuk mengetahui status HIV.

Munculnya stigma di masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus HIV/AIDS. Dalam hidup bermasyarakat, stigma menjadi penghalang ODHA untuk melakukan aktivitas sosial. ODHA menutup diri serta cenderung tidak bersedia berinteraksi dengan keluarga, teman, dan tetangga. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat menganggap bahwa orang dengan HIV positif merupakan orang yang menyimpang seperti perempuan pekerja seks komersial, menggunakan narkoba, dan homoseksual. Kelompok ini juga dianggap memengaruhi epidemi HIV/AIDS dan membuat masyarakat menjadi menolak dan membenci ODHA.

Pemberian informasi yang benar dan lengkap terkait HIV adalah salah satu cara yang efektif untuk menjelaskan tentang pencegahan dan penularan HIV. Seseorang dengan pengetahuan yang baik dan benar terkait HIV dapat menurunkan ataupun menghilangkan stigma pada ODHA. Persepsi masyarakat terhadap penderita HIV memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap dan perilaku memberikan stigma.

Keluarga dan masyarakat desa masih memegang teguh aturan dan tabu sosial yang ketat. Aturan- aturan dan tabu-tabu sosial yang ketat menyebabkan pergaulan pada remaja desa kurang bebas. Remaja putri pedesaan dibatasi hal-hal tabu dalam pergaulannya dengan teman laki-laki. Kontrol sosial serta aturan yang lebih ketat di desa serta adanya pengawasan orang tua terhadap anak mengurangi kemungkinan remaja desa untuk melakukan perilaku seksual yang menyimpang. Hal ini menjadi rendahnya penularan HIV/AIDS dikalangan masyarakat desa. Disisi lain karena pengetahuan seks masih dianggap tabu, dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam pencegahan dan penularan HIV/AIDS pada masyarakat pedesaan.

Keluarga adalah orang terdekat yang berinteraksi dengan ODHA. Menurut hasil penelitian, lebih banyak keluarga memiliki sikap yang positif terhadap ODHA dibandingkan dengan yang memberikan sikap negatif terhadap ODHA. Perilaku keluarga yang memberikan stigma ODHA dapat memperkuat diskriminasi serta penolakan dari masyarakat. Stigma pada ODHA disebabkan karena keluarga merasa malu jika mengetahui salah satu anggota keluarga adalah seorang penderita HIV sehingga dikucilkan dari keluarga. Ketakutan akan diperlakukan secara berbeda membuat ODHA sulit membuka diri dengan orang lain dan takut untuk berbagi pengalamannya, bahkan jika dia sakit. Sebaliknya, dukungan dari orang di sekitar ODHA berdampak pada peningkatan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Dukungan sosial membuat penderita HIV tidak merasa sendiri, merasa disayangi dan mereka lebih berpeluang untuk menggunakan pelayanan Kesehatan atau meningkatkan kepatuhan pengobatan atau terapi antiretroviral (ARV). Keterbukaan dan rasa nyaman yang

dirasakan ODHA membuat mereka lebih mudah untuk menerima informasi.

Selain keluarga, tokoh masyarakat adalah salah satu faktor lingkungan sosial memiliki peranan penting dalam mengurangi stigma terhadap ODHA. Seseorang tokoh masyarakat memberikan stigma terhadap ODHA, masyarakat di sekitarnya memiliki kemungkinan juga akan terpengaruh untuk melakukan hal yang sama. Reaksi masyarakat terhadap ODHA memiliki efek besar pada ODHA.

Tokoh masyarakat berperan penting dalam menurunkan terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA karena tokoh tersebut merupakan role model atau contoh yang biasanya menjadi panutan masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah pedesaan. Tindakan dan sikap mereka dijadikan referensi oleh masyarakat dalam mengubah perilaku mereka, termasuk yang terkait dengan penularan HIV, dan menurunkan stigma terhadap ODHA. Oleh karena itu, pemberian informasi yang komprehensif tentang HIV/AIDS kepada tokoh masyarakat menjadi sangat penting dilakukan oleh petugas kesehatan, agar tokoh masyarakat dapat menularkan dan menyebarkan informasi yang benar kepada masyarakat, termasuk tentang menghilangkan stigma terhadap ODHA.

Menurut Aris Tristanto (2022) Stigma terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) tercermin dalam sikap sinis, rasa takut yang berlebihan, dan pengalaman negatif terhadap ODHA. Banyak orang berpendapat bahwa individu yang terinfeksi HIV dan AIDS seharusnya menerima hukuman akibat perbuatannya sendiri. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa ODHA bertanggung jawab atas penularan HIV dan AIDS. (Aris Tristanto et al., 2022). Walaupun stigma yang terkait dengan kesehatan telah

terkait dengan kondisi kesehatan lain seperti penyakit mental, kanker, dan infeksi menular seksual lainnya, sebagian besar literatur terkait stigma penyakit dalam kurun waktu belakangan ini difokuskan pada stigma dan diskriminasi yang terkait dengan HIV dan AIDS (stigma terkait HIV). (Restall et al., 2023). Jalur penularan HIV turun memperburuk situasi sosial, di mana HIV selain terjadi pada Wanita, juga lebih banyak pada perilaku seks Lelaki Seks Lelaki (LSL) (Rafiq, 2019). Stigma yang sering muncul dalam bentuk diskriminasi atau perlakuan tidak adil oleh individu lain (yang tidak terinfeksi HIV) merupakan salah satu dampak negatif utama yang dihadapi oleh orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) di berbagai lokasi (Chaudoir, 2015).

BAB 4

PSIKOLOGI IBU POSTPARTUM

A. Defensi Ibu Postpartum

Masa nifas dimulai setelah 2 jam postpartum dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil, biasanya berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari, namun secara keseluruhan baik secara fisiologis maupun psikologis akan pulih dalam waktu 3 bulan (Hutabarat, 2021), menurut Ambarwati dalam (Hutabarat, 2021) Masa Nifas (*puerperium*) adalah masa setelah keluarnya plasenta sampai alat-alat reproduksi pulih seperti sebelum hamil dan secara normal masa nifas berlangsung selama 6 minggu atau 40 hari. Menurut Saifudin dalam (Hutabarat, 2021) selama bidan memberikan asuhan pada ibu di masa nifas, sebaiknya bidan mengetahui apa tujuan dari pemberian asuhan selama masa nifas, yaitu

1. Untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik secara fisik maupun psikologis, dimana dalam masa ini peranan keluarga sangat dibutuhkan.
2. Untuk melaksanakan screening yang komprehensif (menyeluruh), dimana bidan melakukan manajemen asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas secara sistematis dimulai dari pengkajian data subjektif, objektif maupun penunjang. Setelah selesai melakukan pengkajian data maka selanjutnya menganalisa data yang telah didapatkan, sehingga tujuan asuhan masa nifas ini

dapat mendeteksi masalah ada atau tidak masalah yang akan terjadi.

3. Mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya, apabila ditemukan adanya masalah maka bidan dapat langsung masuk kelangkah berikutnya yaitu mengobati atau merujuk.
4. Memberikan pendidikan kesehatan tentang nutrisi, keluarga berencana, menyusui, pemberian imunisasi pada bayinya dan perawatan bayi sehat, memberikan pelayanan keluarga berencana.

Asuhan masa nifas diperlukan karena merupakan masa kritis baik ibu maupun bayinya. Diperkirakan bahwa 60% kematian ibu akibat kehamilan terjadi setelah persalinan, dan 50% kematian masa nifas terjadi dalam 24 jam pertama pertama.

Menurut Nugroho dalam (Hutabarat, 2021) terdapat tahapan-tahapan dalam masa nifas yang dibagi kedalam 3 periode yaitu:

1. Puerperium dini yaitu masa kepulihan dimana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Keuntungan dari puerperium dini adalah ibu merasa lebih sehat dan kuat, faal usus dan kandung kemih lebih baik, ibu dapat segera belajar merawat bayinya.
2. Puerperium intermedial yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya sekitar 6-8 minggu. Alat genitalia tersebut meliputi uterus, luka jalan lahir, cervix, endometrium dan ligamen-ligamen.
3. Remote puerperium yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih kembali dan sehat sempurna terutama bagi ibu selama hamil atau melahirkan yang mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan atau tahunan

B. Perubahan Psikologi setelah Melahirkan

Psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yakni *psychology* yang merupakan gabungan dari kata *psyche* dan *logos*. *Psyche* berarti jiwa dan *logos* berarti ilmu. Olehnya itu, secara harfiah dapat dipahami bahwa psikologi adalah ilmu jiwa. Kata *logos* juga sering dimaknai sebagai nalar dan logika. Kata *logos* ini menjadi pengetahuan merata dan dapat dipahami lebih sederhana. Kata *psyche* lah yang menjadi diskusi menarik bagi sarjana Psikologi. Istilah *psyche* atau jiwa masih sulit didefinisikan karena jiwa itu merupakan objek yang bersifat abstrak, sulit dilihat wujudnya, meskipun tidak dapat disangkal keberadaannya. *Psyche* sering kali diistilahkan dengan kata psikis (Saleh, 2018).

Dalam kamus *oxford* misalnya, kita dapat melihat bahwa istilah *psyche* mempunyai banyak arti dalam bahasa Inggris yakni *soul*, *mind*, dan *spirit*. Dalam bahasa Indonesia ketiga kata bahasa Inggris itu dapat dicakup dalam satu kata yakni "jiwa". Di Indonesia, psikologi cenderung diartikan sebagai ilmu jiwa. Dalam bahasa lain juga ditemukan arti yang sama misal bahasa Arab *ilmun-nafsi*, bahasa Belanda *zielkunde*, dan bahasa Jerman *seelenkunde*, yang kesemuanya itu memiliki arti sama yakni ilmu jiwa (Saleh, 2018).

Dapat disimpulkan menurut (Saleh, 2018) bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku individu yang tidak dapat dilepaskan dari proses lingkungan dan yang terjadi dalam diri individu tersebut. Apa yang terjadi dalam diri pribadi tersebut disebut sebagai proses mental.

Pasca persalinan atau masa nifas merupakan salah satu pengalaman yang akan dialami oleh seorang ibu yang baru saja melahirkan terutama pada ibu yang pertama

kalinya melahirkan, pada perkembangan kondisi ibu sering mengalami terjadinya peningkatan dan perubahan emosi dan psikologis yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya penyesuaian pada lingkungan baru, harapan sosial untuk berperilaku lebih baik, masalah dalam sekolah ataupun pekerjaan, dan serta hubungan keluarga yang tidak harmonis, yang akan menyebabkan ibu usia muda harus bisa beradaptasi dengan kehidupan barunya (Nasution, 2022).

Kelahiran anggota baru bagi suatu keluarga yang memerlukan penyesuaian bagi ibu. Perubahan peran seorang ibu memerlukan adaptasi yang harus dijalani, perubahan tersebut berupa perubahan pada emosi dan sosial. Adaptasi psikologis ini menjadi periode kerentanan pada ibu postpartum, karena periode ini membutuhkan peran professional kesehatan dan keluarga. Tanggung jawab ibu postpartum akan bertambah dengan adanya kehadiran bayi yang baru lahir. Ikatan antara ibu dan bayi yang sudah lama terbentuk sebelum kelahiran akan semakin mendorong wanita untuk menjadi ibu yang sebenarnya. Inilah pentingnya rawat gabung atau rooming in pada ibu pasca melahirkan agar ibu dapat leluasa menumbuhkan rasa kasih sayang kepada bayinya tidak hanya dari segi fisik seperti merawat tali pusat, menyusui, mengganti popok tetapi juga dari segi psikologis seperti menatap, mencium, menimang sehingga kasih sayang ibu dapat terus terjaga.

Menurut Sulistyawati dalam (Nasution, 2022) adaptasi psikologi ibu dalam masa nifas berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Adapun fase-fase adaptasi psikologi yang dialami ibu di masa nifas, yaitu

1. Fase *Taking In*, fase ini disebut juga dengan fase ketergantungan yang berlangsung dari hari 1-2 setelah ibu melahirkan. Pada fase ini ibu akan memperlihatkan

bahwa ibu masih pasif dan sangat tergantung dengan orang lain, fokus perhatian ibu masih pada dirinya sendiri, ibu mengingat pengalaman melahirkan dan persalinan yang dialami sehingga ibu suka menceritakannya secara berulang-ulang, ibu lebih suka didengarkan dan kebutuhan tidur meningkat.

2. Fase *Taking Hold*, fase ini dimulai pada hari 3-10 masa nifas. Pada fase ini ibu akan memperlihatkan bahwa ibu sudah menikmati peran sebagai seorang ibu, mulai belajar merawat bayi tetapi masih membutuhkan orang lain untuk membantu ibu, mulai belajar menerima tanggungjawab merawat bayi, selain itu ibu juga akan merasa khawatir akan ketidakmampuan serta tanggungjawab dalam merawat bayi, perasaan ibu sangat sensitif sehingga mudah tersinggung maka dari itu sangat dibutuhkan komunikasi dan dukungan yang positif dari keluarga.
3. Fase *Letting Go*, fase ini terjadi setelah hari ke 10 sampai akhir masa nifas. Pada fase ini ibu sudah bisa menikmati dan menyesuaikan diri dengan tanggungjawab peran barunya. Selain itu keinginan untuk merawat bayi secara mandiri serta bertanggungjawab terhadap diri dan bayinya sudah meningkat dari sebelumnya.

Ibu postpartum dengan HIV/AIDS selain memiliki kecemasan yang tinggi terhadap kondisi bayi dan kelahirannya, stigma yang ada di masyarakat juga menimbulkan masalah psikososial yang dirasakan oleh penderita HIV/AIDS. Diskriminasi dari petugas kesehatan juga masih banyak terjadi. Kapasitas bidan melakukan pertolongan persalinan sebagai tenaga kesehatan profesional belum sepenuhnya dilakukan. Kondisi

diskriminasi penderita HIV/ AIDS ternyata juga terjadi di Negara endemis lainnya (Ernawati, 2018).

Sikap memberi stigma dan diskriminasi dari petugas kesehatan di tatanan pelayanan kesehatan daerah seharusnya tidak boleh terjadi, karena menyebabkan pengasuh tidak mau atau terlambat mengakses fasilitas kesehatan sehingga dikhawatirkan angka kesakitan dan risiko kematian HIV/AIDS meningkat (Ernawati, 2018).

Pasca melahirkan ibu akan mengalami beberapa perubahan baik perubahan fisik maupun perubahan psikologis. Seorang ibu akan mengalami gejala – gejala psikiatrik setelah melahirkan. Beberapa penyesuaian dibutuhkan oleh seorang ibu. Sebagian ibu bisa menyesuaikan diri dan sebagian ibu tidak bisa dalam menyesuaikan dirinya. Bahkan ibu yang tidak bisa menyesuaikan diri akan mengalami berbagai sindrom atau gejala (Susilawati, 2019).

Dalam mengatasi gangguan psikologis pada ibu, ibu harus memiliki pemahaman kepada dirinya. Proses pemahamanV diri pasien HIV tidak lepas dari faktor-faktor penerimaan diri yaitu pemahaman diri, tidak adanya tekanan emosi yang berat, tidak hadirnya hambatan-hambatan dari lingkungan, konsep diri yang stabil, harapan yang realistis, dan sukses yang sering terjadi dalam proses penerimaan diri pada pasien HIV ini bersifat dinamis, sewaktu-waktu bisa berubah (Susilawati, 2019).

C. Tantangan Emosional yang Dihadapi Oleh Ibu dengan HIV / AIDS

Ibu postpartum yang hidup dengan HIV/AIDS menghadapi berbagai tantangan emosional yang kompleks. Tantangan-tantangan ini tidak hanya berasal dari kondisi

medis mereka, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa tantangan emosional utama yang sering dihadapi oleh ibu postpartum dengan HIV/AIDS

1. Stigma Sosial dan Diskriminasi

HIV/AIDS sering kali dikaitkan dengan stigma yang kuat, membuat ibu postpartum merasa terisolasi. Mereka akan enggan untuk mengungkapkan status HIV-nya kepada keluarga atau komunitas karena takut dijauhi atau diperlakukan tidak adil. Isolasi ini dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan.

2. Kecemasan terhadap Transmisi ke Anak

Ibu dengan HIV sering merasa cemas tentang kemungkinan menularkan virus ke bayinya, baik selama kehamilan, persalinan, atau melalui menyusui. Ketakutan ini dapat berdampak negatif pada kondisi emosional mereka dan kepatuhan terhadap pengobatan antiretroviral (ARV)

3. Kurangnya Dukungan Sosial

Kurangnya dukungan dari pasangan, keluarga, atau komunitas dapat memperburuk tekanan emosional. Dukungan praktis, emosional, dan ekonomi sangat penting untuk membantu mereka mengatasi tantangan sehari-hari, namun sering kali tidak tersedia

4. Dilema tentang Pengungkapan Status

Banyak ibu dengan HIV menghadapi dilema tentang kapan dan kepada siapa mereka dapat mengungkapkan status HIV mereka. Ketakutan akan konsekuensi sosial atau konflik keluarga membuat banyak dari mereka memilih untuk merahasiakannya, yang memperburuk rasa kesepian

5. Keterbatasan Akses ke Layanan Kesehatan Mental

Banyak ibu dengan HIV mengalami keterbatasan akses ke layanan dukungan psikologis yang memadai. Di beberapa wilayah, layanan kesehatan mental khusus untuk ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) tidak tersedia, atau stigma terhadap penyakit ini membuat mereka enggan mencari bantuan. Ibu postpartum dengan HIV/AIDS sering kali mengalami kesulitan dalam mengelola emosi dan stres yang disebabkan oleh kombinasi faktor medis dan psikologis. Stres kronis dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka secara signifikan.

6. Efek Terhadap Kepatuhan Pengobatan

Tekanan emosional yang terus-menerus dapat memengaruhi kepatuhan ibu terhadap pengobatan ARV, yang pada akhirnya dapat memperburuk kesehatan fisik dan meningkatkan risiko komplikasi.

7. Perasaan Bersalah dan Harga Diri Rendah

Ibu postpartum dengan HIV/AIDS sering kali merasa bersalah karena mereka menganggap diri mereka bertanggung jawab atas penularan virus kepada anak atau pasangan mereka. Hal ini dapat menurunkan harga diri dan mengganggu kesejahteraan emosional mereka.

8. Pengaruh terhadap Hubungan Keluarga dan Pasangan

HIV/AIDS dapat mempengaruhi dinamika hubungan keluarga dan pasangan, yang sering kali menimbulkan konflik, ketegangan, dan perasaan terasing. Hal ini dapat menambah beban emosional yang dirasakan oleh ibu postpartum.

9. Kesulitan dalam Menjaga Kesehatan Mental dan Kepatuhan Pengobatan

Tekanan emosional yang dialami ibu postpartum dengan HIV/AIDS dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjaga kesehatan mental dan kepatuhan terhadap pengobatan antiretroviral (ARV). Kepatuhan yang buruk terhadap pengobatan dapat memperburuk kondisi fisik dan mental mereka.

D. Psikologis Ibu Postpartum dengan HIV/AIDS

Menurut (Saleh, 2018) bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku individu yang tidak dapat dilepaskan dari proses lingkungan dan yang terjadi dalam diri individu tersebut. Apa yang terjadi dalam diri pribadi tersebut disebut sebagai proses mental.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan arum surya utami tahun 2024 menunjukkan bahwa respon psikososial spiritual yang dimunculkan oleh partisipan selama postpartum ditunjukkan dalam bentuk respon psikologi berupa stress dan sedih dimana stress dan sedih hasil penelitian ini, seorang ibu postpartum tidak dapat berbuat yang terbaik untuk bayinya. Sedangkan respon spiritual yang dimunculkan adalah pasrah dan berdoa. Yang mana berdoa dan dekat dengan Tuhan dapat membuat sedikit tenang suasana hati terutama pada ibu postpartum yang mengidap HIV/AIDS. Dapat disimpulkan bahwa gambaran psikologi ibu selama postpartum dengan HIV/AIDS menunjukkan keadaan yang kurang baik. Psikologi yang jelas terlihat adalah keadaan ibu yang stress dan sedih dengan keadaannya. Hal tersebut menjadikan ibu lebih dekat dengan Tuhan dan pasrah berdoa agar keadaan tidak semakin buruk dan bayi mereka bisa sehat tidak terdeteksi HIV/AIDS. Menurut peneliti respon stress dan sedih yang dialami ibu postpartum dengan HIV/AIDS sangat wajar. Hal

tersebut merupakan gangguan psikologi yang secara alamiah dirasakan oleh ibu dalam masa nifas. Penyesuaian diri ini memang dibutuhkan, ditambah lagi ibu postpartum dalam kondisi terjangkit HIV/AIDS. Butuh penyesuaian psikologi yang lebih ekstra. Karena ibu postpartum dengan HIV/AIDS lebih merasa sedih dan stress serta merasa tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk bayi yang baru mereka lahirkan.

Ibu postpartum dengan HIV/AIDS selain memiliki kecemasan yang tinggi terhadap kondisi bayi dan kelahirannya, stigma yang ada di masyarakat juga menimbulkan masalah psikososial yang dirasakan oleh penderita HIV/AIDS. Berdasarkan penelitian (Susilawati, 2019) dalam mengatasi gangguan psikologis pada ibu, ibu harus memiliki pemahaman kepada dirinya. Proses pemahaman diri pasien HIV tidak lepas dari faktor-faktor penerimaan diri yaitu pemahaman diri, tidak adanya tekanan emosi yang berat, tidak hadirnya hambatan-hambatan dari lingkungan, konsep diri yang stabil, harapan yang realistis, dan sukses yang sering terjadi dalam proses penerimaan diri .

BAB 5

HARAPAN DAN DUKUNGAN

A. Pentingnya Dukungan Sosial Bagi Ibu Postpartum

1. Definisi Dukungan Sosial

Dukungan sosial mencakup bantuan emosional, instrumental, informasi, dan penghargaan yang diberikan oleh keluarga, teman, petugas kesehatan, atau masyarakat. Bentuk dukungan ini membantu ibu postpartum menghadapi tekanan psikologis dan stigma yang sering mereka alami akibat status HIV/AIDS yang melekat pada diri mereka.

2. Manfaat Dukungan Sosial

- a. Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis: Dukungan emosional dari keluarga dan pasangan dapat membantu ibu merasa diterima, dicintai, dan dihargai, sehingga mengurangi perasaan isolasi dan stigma sosial.
- b. Peningkatan Kesehatan: Bantuan dalam bentuk informasi dan instrumental, seperti akses ke perawatan medis dan ARV, memungkinkan ibu mengelola kesehatan mereka lebih baik.
- c. Penguatan Mekanisme Koping: Dukungan sosial memberikan rasa aman dan memotivasi ibu untuk beradaptasi dengan kondisi mereka, meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan mengasuh anak mereka.
- d. Pengurangan Stigma dan Diskriminasi

Dukungan dari lingkungan sosial membantu mengurangi stigma dan diskriminasi yang sering dihadapi oleh ibu dengan HIV/AIDS. Dengan adanya dukungan, ibu merasa lebih berani untuk membuka diri dan mencari bantuan tanpa takut akan penolakan sosial.

3. Peran Dukungan Psikososial

Dukungan psikososial adalah elemen kunci dalam membantu ibu dengan HIV/AIDS untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Program seperti PMTCT (Prevention of Mother-to-Child Transmission) di beberapa rumah sakit telah menunjukkan bahwa dukungan dari keluarga, tenaga kesehatan, dan komunitas dapat meningkatkan keberanian ibu untuk mencari perawatan dan mengatasi stigma sosial.

4. Bentuk Dukungan yang Efektif

- a. Dukungan Emosional: Melibatkan pemberian perhatian, empati, dan kasih sayang untuk membantu ibu merasa dihargai. Ini dapat mengurangi risiko depresi postpartum.
- b. Dukungan Informasi: Penyuluhan tentang HIV/AIDS dan manajemen kesehatan membantu ibu membuat keputusan yang lebih baik terkait perawatan mereka.
- c. Dukungan Instrumental: Bantuan praktis, seperti bantuan finansial, akses ke fasilitas kesehatan, dan distribusi ARV, memberikan dampak langsung pada kualitas hidup.

B. Sumber Dukungan dan Cara Mengatasi Stigma

1. Sumber Dukungan Sosial

- a. Dukungan dari Keluarga

Keluarga adalah sumber dukungan utama bagi ibu postpartum dengan HIV/AIDS. Dukungan dari pasangan, orang tua, dan anggota keluarga lainnya menyediakan fondasi emosional yang kuat. Keluarga yang mendukung dapat membantu ibu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, memberikan motivasi untuk menjalani pengobatan, dan menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih. Peran keluarga sangat penting sebagai sumber utama dukungan emosional dan instrumental. Ketika keluarga menyediakan kasih sayang dan bantuan praktis, ibu lebih mudah menerima kondisi mereka dan menjaga kesehatan mental.

b. Dukungan dari Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan konselor, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan informasi dan emosional. Mereka membantu ibu memahami kondisi mereka, mengelola pengobatan, dan menyediakan akses ke layanan PMTCT (Prevention of Mother-to-Child Transmission) yang esensial untuk kesehatan ibu dan bayi. Penyuluhan oleh komunitas dan tenaga kesehatan dapat membantu mengurangi stigma dan menyediakan akses ke layanan penting.

c. Dukungan dari Komunitas dan Organisasi Non-Profit

Organisasi non-profit dan komunitas lokal sering kali menyediakan kelompok dukungan yang memungkinkan ibu postpartum berbagi pengalaman, belajar keterampilan coping, dan membangun jaringan sosial yang baru. Kelompok dukungan ini berfungsi sebagai ruang aman di mana ibu dapat merasa

diterima dan mendapatkan bantuan praktis serta emosional.

d. Dukungan dari Teman dan Rekan

Teman dan rekan kerja juga dapat menjadi sumber dukungan yang signifikan. Mereka dapat memberikan dukungan emosional melalui percakapan sehari-hari, berbagi pengalaman, dan menawarkan bantuan praktis dalam situasi tertentu.

2. Hambatan dalam Memberikan Dukungan

a. Stigma Sosial

Stigma terkait HIV/AIDS masih menjadi salah satu hambatan utama dalam pemberian dukungan sosial. Ibu postpartum sering kali merasa takut untuk mengungkapkan status HIV mereka karena takut dihakimi atau ditolak oleh masyarakat sekitar. Stigma ini dapat menghalangi mereka untuk mencari dukungan yang dibutuhkan, memperburuk kondisi psikologis mereka. Edukasi kepada masyarakat diperlukan untuk mengurangi diskriminasi.

b. Kurangnya Pengetahuan dan Sumber Daya

Kurangnya pemahaman tentang HIV/AIDS di kalangan keluarga dan masyarakat dapat mengurangi efektivitas dukungan yang diberikan. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun fasilitas kesehatan, juga menjadi hambatan dalam menyediakan dukungan yang memadai.

c. Perubahan Dinamika Keluarga

Kehilangan pasangan atau perubahan dalam struktur keluarga, seperti perceraian atau perpisahan, dapat mengurangi sumber dukungan yang tersedia bagi ibu postpartum dengan HIV/AIDS. Hal ini dapat

menyebabkan peningkatan beban emosional dan kesulitan dalam mengelola kondisi kesehatan mereka.

- d. Keterbatasan Akses: Upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi lokal, dan internasional dapat memperluas akses ke layanan kesehatan yang inklusif.

3. Cara mengatasi stigma

a. Pemberdayaan Individu

1) Pendidikan dan Informasi:

Memberikan edukasi kepada ibu postpartum tentang HIV/AIDS untuk meningkatkan pemahaman dan mengurangi rasa takut terhadap penyakit.

Contoh: Seminar kesehatan, konseling individu.

2) Dukungan Emosional:

Membangun kepercayaan diri melalui terapi kelompok atau dukungan sebaya.

b. Meningkatkan Dukungan Sosial

1) Membentuk kelompok dukungan untuk ibu dengan HIV/AIDS agar mereka dapat berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan moral.

2) Mengajak keluarga untuk memahami kondisi pasien dan memberikan dukungan tanpa menghakimi.

c. Kampanye Anti-Stigma

1) Edukasi Publik:

Mengadakan kampanye untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap HIV/AIDS. *Contoh:* Poster, video, seminar, dan media sosial.

2) Kolaborasi dengan Lembaga:

Melibatkan pemerintah, LSM, dan komunitas untuk menciptakan kebijakan yang mendukung inklusi sosial.

- d. Konseling dan Psikoterapi
 - 1) Konseling individu untuk membantu ibu postpartum memahami dan mengatasi perasaan negatif terkait HIV/AIDS.
 - 2) Terapi keluarga untuk menciptakan lingkungan rumah yang mendukung.
- e. Mengintegrasikan Layanan Kesehatan
 - 1) Menyediakan layanan kesehatan inklusif yang ramah stigma.
 - 2) Pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan empati dan pengurangan diskriminasi.
- f. Penguatan Spiritual

Mendorong ibu untuk mendekatkan diri pada agama atau kepercayaan yang dianut untuk menemukan ketenangan batin dan harapan.

C. Peran Komunitas Dan Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Ibu

1. Peran komunitas

Komunitas memiliki tanggung jawab besar dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap HIV/AIDS melalui:

- a. Program Edukasi Berbasis Komunitas

Memberikan pemahaman yang benar tentang HIV/AIDS, termasuk cara penularan, pencegahan, dan pengobatan. Contohnya: Diskusi kelompok di tingkat RT/RW dengan menghadirkan narasumber terpercaya seperti dokter atau tenaga kesehatan. Dan distribusi materi edukasi (brosur, poster, video pendek) yang ramah dan mudah dipahami.
- b. Pemanfaatan Media Sosial dan Teknologi

Menggunakan platform media sosial (Facebook, Instagram, WhatsApp) untuk menyebarkan informasi positif tentang HIV/AIDS dan pentingnya empati terhadap penderita. Mendorong komunitas untuk menggunakan teknologi seperti aplikasi edukasi kesehatan untuk menjangkau generasi muda.

- c. Pendidikan Melalui Tokoh Masyarakat
Melibatkan tokoh masyarakat, seperti pemuka agama, pemimpin adat, atau kepala desa, untuk menyampaikan pesan yang mendukung penerimaan penderita HIV/AIDS. Pesan dari tokoh yang dihormati cenderung lebih diterima oleh masyarakat lokal.
- d. Edukasi pada Kelompok Khusus
Memberikan edukasi kepada kelompok strategis seperti remaja, ibu rumah tangga, dan pengusaha kecil untuk menciptakan lingkungan inklusif.
Contoh: Kegiatan PKK yang mengangkat tema HIV/AIDS dan pemberdayaan perempuan.
- e. Dukungan Emosional:
Komunitas dapat memberikan dukungan emosional kepada ibu postpartum dengan HIV/AIDS, seperti mendengarkan cerita mereka, memberikan semangat, dan mengurangi perasaan kesepian.
- f. Bantuan Praktis:
Komunitas dapat membantu dengan kebutuhan sehari-hari, seperti memasak, membersihkan rumah, dan menjaga anak-anak.
- g. Advokasi:
Komunitas dapat menjadi suara bagi ibu postpartum dengan HIV/AIDS, memperjuangkan hak-hak mereka, dan mengurangi stigma dan diskriminasi.
- h. Jaringan Dukungan:

Komunitas dapat membantu ibu postpartum dengan HIV/AIDS untuk terhubung dengan layanan kesehatan, organisasi nirlaba, dan sumber daya lainnya.

Adapun beberapa manfaat mendapat dukungan dari komunitas:

- a. Meningkatkan Kualitas Hidup
Dukungan komunitas dapat meningkatkan kualitas hidup ibu postpartum dengan HIV/AIDS.
- b. Mengurangi Stigma
Dukungan komunitas dapat mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap ibu postpartum dengan HIV/AIDS.
- c. Meningkatkan Pengobatan
Dukungan komunitas dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan pengobatan.
- d. Meningkatkan Kesehatan Mental
Dukungan komunitas dapat meningkatkan kesehatan mental ibu postpartum dengan HIV/AIDS.
- e. Mengurangi mitos yang salah seperti "HIV dapat menular melalui sentuhan."

Contoh-contoh Program Komunitas yang dapat diselenggarakan:

- a. Program Dukungan Ibu
Program yang menyediakan dukungan emosional dan praktis bagi ibu postpartum dengan HIV/AIDS.
- b. Kelompok Pendukung
Kelompok yang menyediakan ruang bagi ibu postpartum dengan HIV/AIDS untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan.
- c. Program Pendidikan

Program yang menyediakan informasi tentang HIV/AIDS dan kesehatan reproduksi bagi ibu postpartum.

d. Program Bantuan Kesehatan

Program yang menyediakan bantuan kesehatan dan pengobatan bagi ibu postpartum dengan HIV/AIDS.

2. Peran tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan adalah aktor utama dalam memastikan edukasi yang benar sampai kepada pasien, keluarga, dan masyarakat:

a. Penyampaian Informasi yang Terbuka dan Ilmiah

Tenaga kesehatan perlu menyampaikan fakta medis dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami masyarakat. Menggunakan alat bantu visual seperti diagram, video pendek, atau presentasi interaktif untuk menjelaskan HIV/AIDS.

b. Menyelenggarakan Pelatihan untuk Edukator Komunitas

Melatih kader kesehatan atau relawan lokal agar mampu menjadi penyambung informasi yang kredibel di masyarakat. Materi tes HIV bagi ibu.

c. Kolaborasi dengan Sekolah dan Institusi Pendidikan

Memberikan edukasi HIV/AIDS di sekolah sebagai bagian dari program kesehatan reproduksi. Menjadikan institusi pendidikan sebagai mitra untuk melahirkan generasi bebas stigma.

d. Pendekatan Kultural yang Sensitif

Menyesuaikan pesan edukasi dengan norma dan budaya setempat agar lebih diterima oleh masyarakat. *Contoh:* Menggunakan pendekatan narasi lokal atau cerita rakyat untuk menjelaskan HIV/AIDS.

pelatihan meliputi fakta medis, cara menangani stigma, dan pendekatan empati.

- e. Mengintegrasikan Pendidikan HIV/AIDS ke dalam Layanan Kesehatan Rutin

Setiap kunjungan layanan kesehatan, baik untuk ibu hamil maupun pasien umum, dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi singkat tentang HIV/AIDS. *Contoh:* Saat imunisasi bayi, petugas menyisipkan informasi tentang pentingnya.

3. Strategi untuk Meningkatkan Dukungan

- a. Pendidikan dan Penyuluhan

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang HIV/AIDS melalui program pendidikan dan penyuluhan dapat mengurangi stigma dan diskriminasi. Edukasi ini harus mencakup informasi tentang cara penularan, pengelolaan kondisi kesehatan, dan pentingnya dukungan sosial.

- b. Penguatan Jaringan Dukungan

Membangun dan memperkuat jaringan dukungan melalui kelompok dukungan komunitas, organisasi non-profit, dan layanan kesehatan dapat memberikan akses yang lebih luas bagi ibu postpartum dengan HIV/AIDS untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

- c. Kebijakan dan Program Pemerintah

Pemerintah perlu mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang mendukung akses ke layanan kesehatan, pengobatan, dan dukungan sosial bagi ibu postpartum dengan HIV/AIDS. Program-program seperti PMTCT harus didukung secara finansial dan logistik untuk memastikan keberlanjutannya.

- d. Pelatihan Tenaga Kesehatan

Memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan tentang cara memberikan dukungan yang sensitif dan inklusif kepada ibu postpartum dengan HIV/AIDS dapat meningkatkan kualitas dukungan yang mereka berikan. Tenaga kesehatan yang terlatih dapat membantu ibu mengatasi stigma dan meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan.

D. Hasil Penelitian Terkait Dukungan kepada Ibu

Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh psikologi yang dialami ibu postpartum diantaranya adanya respon sosial dari ibu postpartum itu sendiri yaitu dengan cara merahasiakan status sebagai penderita HIV/AIDS. Salah satu partisipan mengatakan ketika melahirkan suami partisipan belum mengetahui bahwa partisipan penderita penyakit HIV/AIDS. Hingga partisipan menyampaikan jujur kepada suami terkait penyakit tersebut, keluarga suami masih tidak ada yang mengetahui statusnya sebagai penderita HIV. Partisipan sebagai ibu rumah tangga ini mengatakan merahasiakan penyakit ini karena takut dijauhi dan adanya dukungan dari keluarga. Lalu ibu postpartum merasa bersalah selaku pengidap HIV/AIDS kepada keluarga, suami bahkan kepada bayi yang baru saja mereka lahirkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Parwati, 2012) yang menyatakan bahwa ibu yang terdeteksi HIV juga mengalami respon sosial dengan merahasiakan status sebagai penderita HIV untuk mengurangi tekanan akibat stigma di masyarakat. Penderita HIV/AIDS sudah terikat dengan penilaian bahwa mereka mempunyai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang dianut dan adanya perasaan bersalah pada ODHA, *stereotype* atau pemberian cap sebagai penderita HIV, perasaan takut berhubungan dan

menutup status sebagai akibat stigma dari masyarakat. Penderita HIV cenderung untuk merahasiakan status HIV dari keluarga dan masyarakat, hal ini dikarenakan mereka tidak ingin kehilangan sumber kasih sayang, perhatian dan kebutuhan untuk diakui.

Pengaruh psikologi yang selanjutnya adalah dukungan dari keluarga. Kedua partisipan mendapatkan dukungan dari keluarga terkait penyakit yang di deritanya. Yang pertama, Secara emosional salah satu partisipan mendapatkan dukungan emosional dari keluarga baik suami maupun orang tua. Sedangkan satu partisipan hanya mendapatkan dukungan dari kedua orang tuanya. Untuk suami memberi dukungan ketika partisipan sudah melahirkan. Sedangkan mertua partisipan sampai sekarang tidak mengetahui bahwa partisipan menderita HIV/AIDS. Yang kedua, dukungan spiritual didapatkan di salah satu partisipan yang secara spiritual selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Yang ketiga, salah satu partisipan secara fisik mendapat dukungan dari keluarga. Seperti orang tua, suami dan saudara. Untuk satu partisipan tidak mendapatkan dukungan secara fisik dari suami dikarenakan suami tidak tinggal satu rumah dengan ibu postpartum dengan HIV/AIDS. Yang keempat, dukungan informasi dimana kedua partisipan mendapatkan dukungan informasi dari petugas puskesmas dan sesama ODHA HIV/AIDS. Dan yang terakhir salah satu partisipan mendapatkan dukungan finansial dari orang tua dan suami, sedangkan satu partisipan hanya mendapatkan dukungan finansial dari keluarga.

Dukungan keluarga ini sejalan dengan penelitian (Parwati, 2012) yang menyatakan bahwa dukungan keluarga merupakan sumber dukungan natural yang sangat efektif dalam proses perawatan ibu yang terdeteksi HIV selama

persalinan karena dukungan ini bersifat apa adanya, berakar pada hubungan yang telah berakar lama, memiliki keragaman dalam pe-nyampaian, sesuai dengan norma yang berlaku tentang kapan dukungan harus diberikan dan terbebas dari beban psikologis (Kuntjoro, 2002). Dukungan ini dapat berupa dukungan secara fisik, emosional, spiritual.

Hasil penelitian Baidowi ada hubungan positif antara dukungan sosial dengan kualitas hidup pada orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di RSU dr.H. Koesnadi Bondowoso. Kualitas hidup merupakan kemampuan individu dalam menikmati kepuasan selama hidupnya (Ventegodt, Merrick dan Andersen, 2013). Individu harus mampu berfungsi secara fisik, spiritual, psikologis, dan sosial demi mencapai kualitas hidup yang baik. Kualitas hidup pada ODHA itu sendiri memang cukup rentan untuk mengalami penurunan akibat adanya masalah secara fisiologis, maupun masalah secara psikologisnya. ODHA menjadi sangat rentan terserang penyakit akibat terinfeksi HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh. Penurunan system kekebalan tubuh ini akan menyebabkan ODHA mengalami gejala- gejala menyerupai flu, seperti: lemas, batuk yang berkepanjangan, demam, sakit kepala, nyeri otot, nafsu makan buruk, mual, pembengkakan kelenjar, dan bercak di kulit (Greene, Derlega, Yep, & Petronio, 2013).

Banyak sekali ODHA mengalami penurunan berat badan secara drastis hingga sering terkapar lemas ditempat tidur akibat dari infeksi HIV. ODHA akhirnya akan mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari- hari, bahkan mereka tidak mampu untuk bekerja lagi. Ketidakmampuan ODHA untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan bahkan ketidakmampuan untuk bekerja telah mengindikasikan bahwa ODHA mengalami penurunan kualitas hidup. ODHA

sebenarnya tidak hanya mengalami tekanan akibat adanya virus HIV yang menyerang system kekebalan tubuh saja, tetapi ODHA juga dihadapkan pada stigma dan diskriminasi. ODHA sebenarnya membutuhkan dukungan, bukan dikucilkan agar harapan hidup ODHA menjadi lebih panjang. Sarafino (2011) mengungkapkan bahwa dengan adanya dukungan sosial maka akan tercipta lingkungan kondusif yang mampu memberikan motivasi maupun memberikan wawasan baru bagi ODHA dalam menghadapi kehidupannya. Dukungan sosial ini dapat meminimalkan tekanan psikososial yang dirasakan ODHA, sehingga ODHA dapat memiliki gaya hidup yang lebih baik dan dapat memberikan respon yang lebih positif terhadap lingkungan sosialnya. Selain itu, dengan adanya dukungan sosial ini maka ODHA akan merasa dihargai, dicintai, dan merasa menjadi bagian dari masyarakat, sehingga ODHA tidak merasa didiskriminasi yang nantinya dapat berdampak positif bagi kesehatannya.

Menurut Arum Surya utami tahun 2024 dari hasil penelitiannya berpendapat bahwa dukungan keluarga yang didapat kedua partisipan sudah sangat bagus. Orang tua, suami dan saudara sudah memberikan dukungan secara emosional, finansial, bahkan fisik untuk mendukung ibu postpartum dengan HIV/AIDS. Dukungan ini sangat dibutuhkan ibu postpartum dengan HIV/AIDS guna terhindar dari gangguan psikologi yang lebih parah. Serta melindungi ibu postpartum dengan HIV/AIDS dari stigma masyarakat yang kurang baik terhadap penderita HIV/AIDS. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan ibu postpartum yang terinfeksi HIV/AIDS memahami pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi selama persalinan disusun berdasarkan kategori yaitu berhubungan

dekat dengan penderita HIV/AIDS sebagai sumber penularan HIV dengan hasil penelitian ini bahwa penularan HIV/AIDS berawal dari orang terdekat mereka. Oleh sebab itu, kedua partisipan berusaha mencegah agar tidak menular ke bayi mereka. Lalu gejala tertular HIV/AIDS kedua partisipan mengatakan gejala yang dialami kedua partisipan berbeda. Ada yang mengalami gejala, dan yang satu tidak mengalami gejala. Selanjutnya pemahaman minum obat (ARV) secara teratur sejak hamil mencegah penularan HIV ke bayi mendapatkan hasil bahwa kedua partisipan sering diingatkan keluarga dan suami mereka. Sehingga obat diusahakan tetap rutin diminum dari hamil hingga bayi lahir 3 bulan, dan yang terakhir pemahaman tidak menyusui bayi bisa mencegah penularan HIV ke bayi. Hasil yang didapat di penelitian ini adalah kedua partisipan berbeda perlakuan dalam memberikan nutrisi kepada bayinya. Yang satu tidak berani memberikan ASI secara langsung karena takut menularkan ke bayi, sedangkan satu partisipan tetap melakukan menyusui selayaknya seorang ibu, tetapi dengan perasaan takut. Sumber informasi awal partisipan sebagian besar diperoleh dari media sosial, internet, pihak puskesmas setempat.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Wisdayanti, 2021) yang mengatakan bahwa penyampaian informasi kepada Masyarakat dilakukan melalui dua cara, yaitu sosialisasi dalam gedung puskesmas dan luar gedung puskesmas. Sosialisasi di dalam gedung puskesmas dilakukan melalui komunikasi interpersonal dan konseling kepada pasien, serta pemasangan media informasi di ruangan. Sedangkan sosialisasi di luar gedung puskesmas dilakukan dengan sosialisasi di sekolah atau masyarakat desa dengan bantuan kader kesehatan Hal ini sejalan dengan teori (Utami, 2017)

yang mengatakan kesehatan masyarakat agar ODHA diberi pengetahuan, sehingga penularan HIV dan AIDS dapat dikendalikan.

Hasil penelitian (Mulyawan, 2023), menyampaikan bahwa pengetahuan merupakan domain untuk seseorang melakukan tindakan. Seseorang dianggap memahami ditunjukkan melalui menginterpretasikan materi secara benar dan dapat mengaplikasikannya di kehidupan nyata. Pengetahuan tentang pencegahan *HIV/AIDS* diperoleh dari media massa seperti internet dan pelajaran yang ada materi mengenai *HIV/AIDS*. Pengetahuan tentang *HIV/AIDS* merupakan wawasan atau kumpulan informasi yang diperoleh dari hasil pikiran yang dimiliki oleh seseorang meliputi pengertian, tanda gejala, cara penularan, kelompok berisiko tertular *HIV/AIDS*, cara pencegahan, dan dampak yang akan timbul dari penyakit *HIV/AIDS* tersebut.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipan berpengetahuan baik yaitu mengetahui mengenai bahayanya penyakit *HIV/AIDS* dari berbagai informasi yaitu sosial media, internet, media cetak, poster, informasi dari teman ODHA, maupun dari orang sekitar seperti keluarga yang dapat mempengaruhi pengetahuan ibu postpartum.

Peneliti berpendapat bahwa pengetahuan baik ini disebabkan oleh pemahaman partisipan tentang *HIV/AIDS* yang didapatkan dari berbagai sumber informasi seperti media massa, sosial media, teman, pegawai medis, dan keluarga. Namun masih ada yang memiliki pengetahuan cukup dikarenakan responden belum cukup mendapatkan informasi yang tepat tentang *HIV/AIDS* dan dari partisipan yang memiliki pengetahuan cukup tidak menjawab pertanyaan dengan lengkap saat peneliti melakukan wawancara tentang *HIV/AIDS*.

Pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah umur. Umur menggambarkan kematangan fisik, psikis dan sosial yang mempengaruhi proses berumah tangga. Ini berarti bahwa umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penangkapan informasi yang pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan pengetahuan seseorang, termasuk pengetahuan tentang *HIV/AIDS* pada ibu posrpartum.

BAB 6

PENUTUP

Stigma terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) mencerminkan bias kelas sosial yang mendalam. Penyakit ini sering dikaitkan dengan perilaku tertentu, yang menjadi pembenaran untuk berbagai bentuk ketidakadilan sosial. Stigma terhadap ODHA terjadi hampir di semua lapisan masyarakat, termasuk keluarga, teman sebaya, lingkungan sekolah atau kerja, dan media massa. Faktor utama yang memicu stigma ini adalah rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat mengenai HIV/AIDS. Selain itu, kurangnya sosialisasi atau penyuluhan terkait HIV/AIDS, terutama mengenai cara penularan dan pencegahannya, juga menjadi penyebab kesalahpahaman tentang ODHA.

Stigma masyarakat berhubungan erat dengan stigma pada diri sendiri, yang terbentuk saat seseorang menerima stigma yang diberikan masyarakat sebagai sebuah kebenaran. Jika masalah stigma ini tidak segera diselesaikan, dampaknya akan semakin luas dan mendalam di masyarakat. ODHA sering kali disisihkan dan ditolak, yang berujung pada dampak langsung dalam proses pengobatan dan perawatan mereka. Banyak ODHA merasa takut, malu, diacuhkan, dan menghadapi diskriminasi, serta kurangnya dukungan positif. Hal ini semakin diperburuk dengan persepsi negatif yang berkembang di kalangan ODHA itu sendiri, sehingga mereka kehilangan rasa percaya diri dan menjadi semakin tertekan.

Selain stigma sosial, ODHA juga menghadapi beban psikologis yang berat, seperti rasa malu dan rendah diri, yang

pada akhirnya memengaruhi daya tahan tubuh mereka. Penurunan daya tahan tubuh akibat serangan virus HIV akan mempermudah terjadinya infeksi oportunistik, sehingga ODHA semakin sulit berfungsi sosial dengan baik. Situasi ini menjadi lebih kompleks bagi ibu postpartum dengan HIV/AIDS, yang menghadapi tantangan emosional seperti stigma sosial, kecemasan akan transmisi ke anak, perasaan bersalah, isolasi sosial, dan kesulitan mengelola emosi serta stres.

Karena itu, penting untuk mengembangkan intervensi holistik dan komprehensif yang tidak hanya fokus pada aspek medis tetapi juga mendukung kesehatan mental dan sosial ODHA, khususnya ibu postpartum dengan HIV/AIDS. Dukungan dari keluarga, komunitas, serta layanan kesehatan mental yang terintegrasi dapat memainkan peran penting dalam membantu mereka mengatasi tantangan emosional ini dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dukungan sosial memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup ibu postpartum dengan HIV/AIDS. Dengan dukungan yang memadai dari keluarga, tenaga kesehatan, dan komunitas, ibu-ibu ini dapat menghadapi tantangan yang ada dengan lebih baik. Namun, untuk mencapai dukungan yang optimal, diperlukan upaya kolaboratif dalam mengurangi stigma, meningkatkan pendidikan, dan memperkuat jaringan dukungan yang tersedia.

Mengatasi stigma terhadap ibu postpartum dengan HIV/AIDS memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pemberdayaan individu, dukungan sosial, edukasi publik, dan penguatan spiritual. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalkan stigma sehingga ibu dengan HIV/AIDS dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan penuh harapan.

Selain itu, berbagai inisiatif telah dilaksanakan untuk mengatasi stigma melalui advokasi kebijakan yang inklusif.

Misalnya, pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat bekerja sama dalam membuat program-program edukasi yang menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan rendah tentang HIV/AIDS. Media massa juga dapat dilibatkan untuk mempromosikan cerita positif tentang ODHA, sehingga citra negatif yang selama ini ada dapat berubah secara perlahan.

Sumber utama stigma, seperti ketakutan, moralitas, dan representasi negatif di media massa, telah memperkuat isolasi sosial, diskriminasi, dan penolakan ODHA dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Dampak ini menciptakan hambatan serius bagi ODHA untuk mendapatkan perawatan medis yang layak, dukungan psikologis, dan menjalani kehidupan yang produktif.

Namun demikian, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi stigma melalui pendekatan edukasi, advokasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Penyediaan informasi yang benar mengenai HIV/AIDS, termasuk jalur penularan dan fakta bahwa HIV tidak selalu berhubungan dengan perilaku amoral, menjadi langkah penting untuk mengikis stigma yang ada. Dukungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah juga menjadi faktor kunci untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi ODHA.

Sebagai penutup, penghapusan stigma terhadap ODHA adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi lintas sektor. Dengan mengedepankan empati, edukasi yang tepat, dan kebijakan yang inklusif, masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung ODHA untuk hidup secara bermartabat dan berkontribusi bagi komunitas mereka. Hanya dengan langkah-langkah ini, perjuangan melawan HIV/AIDS dapat dilakukan secara efektif tanpa meninggalkan siapa pun di belakang.

Pada akhirnya, kesuksesan dalam mengatasi stigma juga bergantung pada kemampuan kita sebagai masyarakat untuk memahami kompleksitas isu HIV/AIDS. Stigma tidak hanya mencerminkan kekurangan dalam pengetahuan, tetapi juga adanya ketakutan dan prasangka yang telah lama mengakar. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan harus bersifat jangka panjang dan melibatkan semua elemen masyarakat, mulai dari individu hingga institusi besar.

Selain pemberdayaan individu, dukungan berbasis komunitas dapat memperkuat upaya menghapus stigma. Inisiatif lokal, seperti kelompok dukungan bagi ODHA, dapat menjadi tempat untuk berbagi pengalaman dan membangun rasa solidaritas. Hal ini memberikan ruang aman bagi ODHA untuk mendapatkan dukungan emosional dan meningkatkan rasa percaya diri mereka.

Melalui upaya kolektif ini, kita dapat menciptakan masa depan di mana ODHA tidak lagi dihantui oleh stigma dan diskriminasi, melainkan diterima sebagai bagian dari masyarakat yang setara dan berharga. Langkah ini tidak hanya akan membantu ODHA, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan kemanusiaan di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Dengan kerja sama yang erat, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif dan penuh empati, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk hidup dengan martabat dan harapan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal dan handayani. 2020. Stigma dan Diskriminasi Orang Dengan HIV/AIDS Antara Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 5, No. 3 Hal. 133-141
- Aris Tristanto, 2022. stigma masyarakat dan stigma pada Diri sendiri terkait HIV dan AIDS : Tinjauan Literatur. *Media publikasi promosi kesehatan Indonesia. MPPKI* (April, 2022) Vol. 5. No 4
- Arum Surya Utami. 2024. Laporan Penelitian Studi Kualitatif: Gambaran Psikologis Ibu Postpartum Dengan Hiv/Aids Di Puskesmas Sentani Tahun 2024. *Stikes Jayapura*.
- Azza, A. (2010). The Woman Burden of HIV/AIDS Patient in Gender Perspective. *Jurnal Ners*, 5(2), 118-126.
- Burhan, R. F. (2014). Gambaran kebermaknaan hidup orang dengan hiv/aids (odha) serta tinjauannya menurut Islam. *Jurnal Psikogenesis*, 2(2), 110-122.
- Cory'ah, F. A. (2018). Hubungan Faktor Resiko Hiv/Aids Dengan Pelaksanaan Vct Di Kth (Klinik Tes Hiv/Aids) Mandalika Rsud Praya Tahun 2013. *Jurnal Kesehatan Prima*, 8(1), 1216-1223.
- Chambers, L. A., Rueda, S., Baker, D. N., Wilson, M. G., Deutsch, R., Raeifar, E., Rourke, S. B., Adam, B., Bacon, J., Cairney, J., Husbands, W., Jackson, R., Jolly, R. J., Li, A., Logie, C., Noh, S., Millson, P., Strike, C., Tharao, W. E., & Travers, R. (2015). Stigma, HIV and health: A qualitative synthesis. *BMC Public Health*, 15(1), 1–17. <https://doi.org/10.1186/s12889-015-2197-0>

- Chaudoir, S. R. (2015). From Conceptualizing to Measuring HIV Stigma: A Review of HIV Stigma Mechanism Measures. *AIDS Behav.*, 13(6), 1160–1177. <https://doi.org/10.1007/s10461-009-9593-3>. From
- Darmawan, B. A., & Permatasari, I. (2022). Upaya penurunan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA menuju Indonesia bebas HIV/AIDS 2030. Faculty of Public Health Universitas Indonesia, December.
- Deepa Rao et al. (2012). A Structural Equation Model of HIV-Related Stigma, Depressive Symptoms, and Medication Adherence. *Bone*, 23(1), 1–7. <https://doi.org/10.1007/s10461-011-9915-0>. A
- Fasoulakis, Z. (2017). The social stigma of HIV – AIDS : society ' s role. 111–118.
- Handayani, S., Mahmud, A., Studi, P., Masyarakat, K., Tinggi, S., Kesehatan, I., Makassar, T., Provinsi, B., & Selatan, S. (2020). Stigma dan Diskriminasi Orang Dengan HIV/AIDS Antara Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan Di Sulawesi Selatan Stigma and Discrimination of People With HIV / AIDS Between Urban and Rural Communities in South Sulawesi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(3), 133–141.
- Ernawati, E. &. (2018). The Practice Of Mother With Hiv/Aids In Order To Prevent Infection Transmission To The Child. *Indonesian Nursing Journal Of Education And Clinic (Injec)*,, 1(1), 74-82.
- Hardjito, K. P. (2018). Hubungan keikutsertaan kelas ibu hamil terhadap kesiapan perawatan bayi pada fase taking in di wilayah kerja Puskesmas Wates Kabupaten Kediri. *Global Health Science*, 3(1), 61-67.

- Hutabarat, J. &. (2021). Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas.
- Indriastuti, N. A. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Peran sebagai Ibu pada Perempuan dengan HIV/AIDS di Yogyakarta. *Mutiara Medika: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 15(1), 75-83.
- Ismi, W. (2023). Karakteristik Orang Dengan Hiv/Aids Di Rsud Bumiayu Periode Tahun 2018-2022. (Doctoral dissertation, Universitas Al-Irsyad Cilacap).
- Kurniawati, A. (2022). Upaya Dinas Kesehatan Kota Jambi Dalam Penanggulangan Penyebaran Hiv Dan Aids Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013. Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (Doctoral dissertation, Universitas batanghari).
- Kusuma, H. (2015). Membangun kesadaran publik akan hiv aids melalui social marketing. *Jurnal Manajemen: Untuk Ilmu Ekonomi dan Perpustakaan*, 1(1).
- Mulyawan, A. (2023). Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Remaja Tentang Pencegahan Hiv/Aids. *Jurnal Pendidikan Keperawatan dan Kebidanan*, 2(4), 28-41.
- Nasution, M. Z. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Depresi Post Partum Di Puskesmas Siabu Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021.
- Nyblade L. et al. (2018). HIV Stigma Reduction for Health Facility Staff: Development of a Blended- Learning Intervention. *Front. Public Health* 6:165.
- Notoatmodjo. (2012). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : PT Rineka Cipta.

- Nurdin, I. &. (2019). Metodologi penelitian sosial. media Sahabat Cendekia.
- Nursalam. (2012). Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan. Jakarta : Salemba medika.
- Parwati, D. M. (2012). Pengalaman Ibu yang Terdeteksi HIV tentang Dukungan Keluarga Selama Persalinan. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 8(1), 35-41.
- Purwaningsih, S. S. (2018). Perkembangan HIV dan AIDS di Indonesia: Tinjauan sosio demografis. Jurnal Kependudukan Indonesia, 3(2), 75-95.
- Rafiq, A. (2019). Harap-Harap Cemas Lelaki Seks dengan Lelaki. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2563383>
- Restall, G., Ukoli, P., Mehta, P., Hydesmith, E., & Payne, M. (2023). Resisting and disrupting HIV- related stigma: a photovoice study. BMC Public Health, 23(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-16741-1>
- Saleh, A. A. (2018). Pengantar psikologi.
- Susilawati, S. &. (2019). Identifikasi Psikologis Ibu Dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV) di Cilacap. Siklus : Journal Research Midwifery Politeknik Tegal, 8(1), 1-7.
- Utami, E. H. (2017). Konsep Diri Wanita Dengan Hiv Dan Aids Di Kota Makassar Tahun 2017.
- Wahyu, S. T. (2012). Konsep diri dan masalah yang dialami orang terinfeksi HIV/AIDS. Konselor, 1(2).

- Wahyuningsih, S. N. (2017). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency/Aquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) Di Kota Surakarta. *jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2).
- Widyasih, H. &. (2019). Hubungan antara lama terdiagnosa dengan kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS di yayasan victory plus tahun 2019. (Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta).
- Wisdayanti, D. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas Medan Belawan . (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)
- Violin Irene Ninef, dkk. 2023. Stigma dan Diskriminasi Sosial Terhadap Pengidap HIV-AIDS: Peran Masyarakat di Wilayah Timur Indonesia. *Health Information: Jurnal Penelitian*, 2024, vol. 14, no. 2, Juli – Desember, ISSN: 2085-0840 / 2622-5905
- Zeng, C. et al. (2018). A structural equation model of perceived and internalized stigma, depression, and suicidal status among people living with HIV/AIDS. *BMC Public Health* (Vol. 138). <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5053-1>

PROFIL PENULIS



Bdn. Susi Lestari, S.ST., M.Kes, Penulis lahir di Hessa Air Genting Agustus 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Dosen Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayapura. Penulis menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan di Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan tahun 2009, melanjutkan DIV Bidan Pendidik di Universitas Respati Yogyakarta tahun 2012, melanjutkan Pasca Sarjana Jurusan Kesehatan Reproduksi di Universitas Respati Indonesia Jakarta tahun 2013 dan melanjutkan Pendidikan Profesi Bidan di Universitas Kadiri Pamenang Jawa timur tahun 2020. Penulis memulai karir di Program Studi Kebidanan STIKES Nauli Husada Sibolga tahun 2013-2014. Tahun 2015 hingga saat ini bergabung di Program Studi Kebidanan STIKES Jayapura. Selain mengajar, penulis juga aktif menulis buku sebagai upaya pengembangan diri, memberikan ilmu yang bermanfaat serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Buku ini buku kelima penulis, buku pertama berjudul "Perbedaan ASI Eksklusif Dengan Susu Formula", buku kedua berjudul "Asuhan Kebidanan Kehamilan Untuk D-III Kebidanan", Buku ketiga berjudul "Melangkah Menuju Kebidanan yang Berdaya", buku keempat berjudul "KB dan Pelayanan Kontrasepsi". Email Penulis: Lestari49711@gmail.com

PROFIL PENULIS



Arum Surya Utami, S.Tr.Keb., M.Keb., lahir di Banyumas, pada tanggal 21 Mei 1996. Saat ini penulis tinggal di Sentani Kabupaten Jayapura. Pendidikan tinggi ditempuh mulai dari DIII Kebidanan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan (Lulus 2017), DIV Kebidanan di Universitas Aisyiyah (Lulus 2018), S2 Ilmu Kebidanan di Universitas Aisyiyah (Lulus 2021). Aktivitas penulis saat ini adalah mengajar pada jenjang sarjana Program Studi Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Jayapura. Jalin kerja sama dengan penulis via surel arumsurya23@gmail.com



Eftyaningrum Dwi Wahyu Astutik, M.Tr.Keb., Dosen Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayapura. Penulis lahir di Malang pada tanggal 28 April 1986. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayapura. Menyelesaikan pendidikan D3 Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang pada tahun 2008, dan melanjutkan pendidikan D4 Kebidanan di Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang dengan menyelesaikannya pada tahun 2013. Melanjutkan pendidikan pada program pasca sarjana (S2) di Poltekkes Kemenkes Semarang dengan mengambil jurusan Magister Terapan Kebidanan dan lulus pada tahun 2020. Penulis saat ini

masih aktif dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang keilmuan kebidanan. Selain aktif dalam menjalankan tugas sebagai dosen, penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang tergabung dalam Pengurus Cabang IBI Kabupaten Jayapura.



Endah Purwanti Handayani, S.ST., M.Tr.Keb., Penulis lahir di Manokwari tanggal 02 Mei 1990. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayapura sejak Januari Tahun 2013. Menyelesaikan pendidikan D4 pada Bidan Pendidik di Universitas Respati Yogyakarta dan

melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Terapan Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Semarang. Penulis hobi dalam membuat konten edukasi dan jika memanfaatkan waktu luang dengan membaca dan juga menjadi moderator ataupun narasumber. Silahkan jika hendak menghubungi penulis melalui email: endahpurwantihandayani@gmail.com

PROFIL PENULIS



Hasnia, S.Tr.Keb., M.Keb., Dosen Program Studi Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayapura. Penulis lahir di Enrekang tanggal 05 Juli Tahun 1988 berdomisili di Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi S1 Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Jayapura. Penulis telah menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan di STIKES Jayapura kemudian melanjutkan studi ke Diploma IV Kebidanan di STIKES Mega Buana Palopo dan melanjutkan Pendidikan Magister (S2) pada Jurusan Ilmu Kebidanan di Universitas Hasanuddin, dalam pengembangan karirnya sebagai dosen, penulis menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dengan aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam bidang ilmu kebidanan. Penulis juga aktif dalam menulis buku dan ini adalah buku yang kedua, buku pertama berjudul "Melangkah Menuju Kebidanan yang Berdaya" yang merupakan serial buku *Chapter*. Email: hasnianhiya@gmail.com

SINOPSIS BUKU

Tantangan emosional yang dihadapi oleh ibu postpartum dengan HIV/AIDS sangat beragam dan saling terkait. Stigma sosial, kecemasan terhadap transmisi ke anak, perasaan bersalah, isolasi sosial, serta kesulitan dalam mengelola emosi dan stres adalah beberapa di antaranya yang signifikan mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan intervensi yang holistik dan komprehensif, yang tidak hanya fokus pada aspek medis tetapi juga mendukung kesehatan mental dan sosial ibu postpartum dengan HIV/AIDS. Dukungan dari keluarga, komunitas, serta layanan kesehatan mental yang terintegrasi dapat memainkan peran kunci dalam membantu mereka mengatasi tantangan emosional ini dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dukungan sosial memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup ibu postpartum dengan HIV/AIDS. Dengan adanya dukungan yang memadai dari keluarga, tenaga kesehatan, dan komunitas, ibu-ibu ini dapat mengatasi tantangan yang mereka hadapi dengan lebih baik. Namun, untuk mencapai dukungan yang optimal, perlu adanya upaya kolaboratif dalam mengurangi stigma, meningkatkan pendidikan, dan memperkuat jaringan dukungan yang ada.

Mengatasi stigma terhadap ibu postpartum dengan HIV/AIDS memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemberdayaan individu, dukungan sosial, edukasi publik, dan penguatan spiritual. Dengan langkah ini, stigma dapat diminimalkan, sehingga ibu dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan penuh harapan

Tantangan emosional yang dihadapi oleh ibu postpartum dengan HIV/AIDS sangat beragam dan saling terkait. Stigma sosial, kecemasan terhadap transmisi ke anak, perasaan bersalah, isolasi sosial, serta kesulitan dalam mengelola emosi dan stres adalah beberapa di antaranya yang signifikan mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan intervensi yang holistik dan komprehensif, yang tidak hanya fokus pada aspek medis tetapi juga mendukung kesehatan mental dan sosial ibu postpartum dengan HIV/AIDS. Dukungan dari keluarga, komunitas, serta layanan kesehatan mental yang terintegrasi dapat memainkan peran kunci dalam membantu mereka mengatasi tantangan emosional ini dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dukungan sosial memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup ibu postpartum dengan HIV/AIDS. Dengan adanya dukungan yang memadai dari keluarga, tenaga kesehatan, dan komunitas, ibu-ibu ini dapat mengatasi tantangan yang mereka hadapi dengan lebih baik. Namun, untuk mencapai dukungan yang optimal, perlu adanya upaya kolaboratif dalam mengurangi stigma, meningkatkan pendidikan, dan memperkuat jaringan dukungan yang ada.

Mengatasi stigma terhadap ibu postpartum dengan HIV/AIDS memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemberdayaan individu, dukungan sosial, edukasi publik, dan penguatan spiritual. Dengan langkah ini, stigma dapat diminimalkan, sehingga ibu dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan penuh harapan

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7097-49-1



9

786347

097491